



**UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE BIOLOGIA
MESTRADO PROFISSIONAL EM DIVERSIDADE E INCLUSÃO
CMPDI**



TATIANA PEREIRA VEIGA ZAHAL

**ANÁLISE DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO TEA
NA EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
MARICÁ: CONSTRUÇÃO DO GUIA DE PERCURSO
NESTE MUNICÍPIO**

Dissertação submetida à Universidade Federal Fluminense visando à obtenção do grau de Mestre em Diversidade e Inclusão

Orientadora: Dra. Suelen Adriani Marques

NITERÓI

2025



TATIANA PEREIRA VEIGA ZAHAL

**GUIA DE PERCURSO DO ATENDIMENTO NA
EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA ALUNOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO DO AUTISMO NA REDE MUNICIPAL DE
MARICÁ**

Trabalho desenvolvido no Curso de Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão da
Universidade Federal Fluminense

Texto submetido à Universidade Federal Fluminense
como requisito para obtenção do título de Mestre em
Diversidade e Inclusão.

Orientadora: Dra. Suelen Adriani Marques

Ficha catalográfica automática - SDC/BCV
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Z19a Zahal, Tatiana Pereira Veiga
ANÁLISE DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO TEA NA EDUCAÇÃO E
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARICÁ : CONSTRUÇÃO DO GUIA DE PERCURSO
NESTE MUNICÍPIO / Tatiana Pereira Veiga Zahal. - 2026.
74 f.

Orientador: Suelen Adriani Marques.
Dissertação (mestrado profissional)-Universidade Federal
Fluminense, Instituto de Biologia, Niterói, 2026.

1. Transtorno do Espectro do Autismo. 2. Educação
infantil. 3. Programa Saúde na Escola. 4. Diagnóstico
precoce.. 5. Produção intelectual. I. Marques, Suelen
Adriani, orientadora. II. Universidade Federal Fluminense.
Instituto de Biologia. III. Título.

CDD - XXX

Bibliotecário responsável: Debora do Nascimento - CRB7/6368

TATIANA PEREIRA VEIGA ZAHAL

GUIA DE PERCURSO DO ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO NA REDE MUNICIPAL DE MARICÁ

Texto submetido à Universidade Federal Fluminense como requisito para obtenção do título de Mestre em Diversidade e Inclusão.

Banca Examinadora:

Profa Dra. Suelen Adriani Marques – (Presidente da Banca - Orientador) CMPDI

Profa Dra. Diana Negrão Cavalcanti - (Membro Titular Interno)– CMPDI

Profa Dra. Viviane Lione (Membro Titular Interno)– CMPDI

Profa Dra. Cremilda Barreto Couto (Membro Titular Externo)– SME Casimiro de Abreu

Profa Dra. Ruth Maria Mariani Braz (Membro Suplente Interno)– CMPDI

Profa Dra. Anne Caroline Rodrigues dos Santos (Membro Suplente Externo e Revisora)–
Suprema

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus pela benção do dom da vida e a oportunidade de caminhar em direção a conquista dos meus sonhos.

Agradeço todo apoio do meu esposo, Fabio Zahal durante o processo seletivo e em todos momentos que me senti cansada, desanimada e incapaz de seguir em frente. As minhas filhas Lavinia e Antonella que de forma amorosa me deram ânimo, pois seus sorrisos e alegria me trouxeram leveza no processo que trouxe até aqui. Aos meus pais que me ensinaram o valor da educação a qual não tiveram acesso por todas as dificuldades do seu tempo de infância. A minha irmã que mesmo no seu período de dor e luto também me apoiou.

Agradeço também aos professores que me transmitiram muito mais do que conhecimento, em especial a minha orientadora Suelen por cada conhecimento novo na construção da pesquisa.

Aos meus colegas de turma que foram solidários e cooperativos, e em especial a Danielle Diniz e Cássia Cortines, que se tornaram minhas amigas e companheiras de trabalhos acadêmicos e de vida, e muito contribuíram nessa jornada.

Não poderia esquecer de Luiza, Mônica e Giselle, companheiras de trabalho, que foram amigas que fizeram parte deste processo ao me apoiarem.

Enfim, gratidão a todos que de alguma forma contribuíram com incentivo, abraços apertados e palavras de estímulo.

SUMÁRIO

Lista de ilustrações (gráficos)	7
Lista de ilustrações (tabelas)	7
Lista de abreviaturas, siglas e símbolos	9
Resumo	10
Abstract	10
1.Introdução	12
1.1. Apresentação.....	12
1.2. Contextualização do Município de Maricá	14
1.3. Educação Infantil.....	17
1.4 O Transtorno do Espectro Autista (TEA).....	19
1.4.1. Diagnóstico e Intervenção Precoce.....	23
1.4.3. Desafios do Diagnóstico Precoce.....	28
1.5 O Direito à Inclusão.....	32
1.6 Programa da Saúde na Escola (PSE).....	36
1.6.1 O PSE como possível estratégia para o diagnóstico precoce do TEA.....	38
2 Objetivos da Pesquisa.....	41
2.1 Objetivo Geral.....	41
2.2 Objetivos Específicos	41
3 Metodologia.....	42
3.1 Método da Pesquisa.....	42
3.2 Revisão de Literatura	42
3.2.1 Processo de seleção dos Estudos.....	42
3.3. Pesquisa Documental.....	45
3.3.1. Busca no site da Prefeitura Municipal de Maricá	46
3.3.2.Caracterização dos Documentos.....	51
3.3.Procedimentos de análise dos dados	52
3.4 Categorias de análise.....	53
4. Procedimentos de Análise dos Documentos.....	
4.1. Análise da política de atendimento ao TEA em Maricá.....	
4.2. Caracterização Geral dos Documentos.....	
4.3. Intersetorialidade entre saúde e educação no atendimento ao TEA: Análise documental	
4.4 Direitos, Inclusão e políticas públicas para crianças com TEA na Educação Infantil.....	70
5. Resultados	
5.1. Síntese dos achados da Revisão de Literatura.....	72
5.1. Síntese dos achados da Revisão Documental.....	
6 Produto Educacional.....	74
6.1 Apresentação do Produto Educacional.....	74
6.2. Estratégias de Implementação e Alcance do Guia	
6.3. Alcance e Limitações do Guia.....	
7 Conclusão.....	77
8 Referências Bibliográficas.....	79
9 Apêndices	83
9.1. Percorso Detalhado de navegação no site Institucional	

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Número de escolas da rede municipal de ensino de Maricá (2014-2024).....	18
Gráfico 2: Crescimento do número de matrículas na rede pública de ensino de Maricá (2014-2024).....	19
Gráfico 3: Crescimento do número de matrículas na educação especial da rede pública de ensino de Maricá (2014-2024).....	34
Gráfico 4: Distribuição de matrículas na educação especial na rede pública de ensino de Maricá (2014-2024).....	35

LISTA DE TABELAS E QUADROS

Tabela 1: Dados epidemiológicos prevalência de TEA nos Estados Unidos.....	22
Quadro 1: Resumo das Recomendações da Linha de Cuidados para Pessoas com TEA	
Quadro 2: Critérios para Análise Preliminar.....	46
Quadro 3: Matriz de Caracterização temática utilizada para análise dos dados coletados.....	56
Quadro 4: Caracterização do conjunto de documentos.....	63
Quadro 5: Matriz de análise temática categoria 1.....	65
Quadro 6: Matriz de análise temática categoria 2.....	68
Quadro 7: Matriz de análise categoria 3.....	71
Quadro 8: Serviços Públicos Municipais.....	
Quadro 9: Síntese dos achados documentais da pesquisa.....	73
Quadro 10: Estrutura do Produto Educacional.....	40

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: FLUXOGRAMA 1: Processo de seleção dos artigos incluídos.....	44
Figura 2: Detalhamento da Casa do Autista de Maricá	49
Figura 3: Detalhamento do Centro de Reabilitação de Maricá.....	49
Figura 4: Detalhamento do SAREM de Maricá	50
Figura 5: Detalhamento do serviço público de Equoterapia de Maricá.....	50
Figura 6: Detalhamento do CAIF de Maricá.....	51

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS

AFR - Associação Fluminense de Reabilitação
ANDEF- Associação Niteroiense de Deficientes Físicos
APD- Atendimento Pedagógico Domiciliar
APS- Atenção Primária de Saúde
AVD- Atividade de Vida Diária
BNCC - Base Nacional Comum Curricular
CAIF- Centro de Referência em Políticas Inclusivas de Maricá
CDC - Central for Diseases Control and Prevention
CIPITEA- Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
CNS - Conselho Nacional de Saúde
DCNEB- Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica
DCNEI- Diretrizes Curriculares para Educação Infantil
DNPM - Desenvolvimento Neuropsicomotor
DSM 5 - Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - 5
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
LDB - Lei de Diretrizes e Bases
ONU- Organização das Nações Unidas
PDF- Formato de Documento Portátil
PME - Plano Municipal de Educação
PNE - Plano Nacional da Educação
PSE- Programa Saúde na Escola
RJ - Rio de Janeiro
SAREM - Serviço de Atendimento de Reabilitação Especial de Maricá
SBP - Sociedade Brasileira de Pediatria
SUS - Sistema Único de Saúde
TEA - Transtorno do Espectro do Autismo
UBS- Unidade Básica de Saúde
UFF - Universidade Federal Fluminense
UNESCO- Organização das nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura

RESUMO

O aumento da incidência do transtorno do espectro autista (TEA) mundialmente tem se tornado uma questão sensível para o sistema educacional. E o diagnóstico e intervenção precoce facilitam o processo de inclusão, socialização e desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo dessa criança. Eventualmente, pais “de primeira viagem” que tenham pouco convívio prévio com crianças e seus processos durante o desenvolvimento podem ficar pouco atentos ou muito ansiosos nesta fase. Adicionalmente, a dificuldade em saber como proceder para diagnóstico ao detectar alguma alteração pode acentuar o estresse familiar. O presente estudo tem como objetivo realizar análise documental das estratégias de articulação intersetorial entre os setores de saúde e educação, no contexto do Programa Saúde na Escola (PSE), para a identificação precoce e o atendimento a crianças da educação infantil com TEA na rede municipal de Maricá, RJ. Por meio da análise das informações públicas disponíveis no site e nos documentos da prefeitura do município de Maricá, buscamos sistematizar o conhecimento sobre o caminho para diagnóstico e intervenção precoce do TEA no município, e elaborar o Guia, que será disponibilizado gratuitamente na rede educacional, para servir como um instrumento e fornecer para pais/responsáveis de crianças com TEA, educadores e profissionais da saúde, informações sistematizadas de orientação sobre a interface entre os setores de educação e saúde, a fim de promover um atendimento integral e colaborativo. Acredita-se que o Guia facilite o acesso e aperfeiçoe o cuidado intersetorial às crianças com TEA na rede pública municipal.

Palavras- chave: Transtorno do Espectro do Autismo, educação infantil, Programa Saúde na Escola, diagnóstico precoce.

ABSTRACT

The increasing incidence of Autism Spectrum Disorder (ASD) worldwide has become a sensitive issue for the education system. Early diagnosis and intervention can aid inclusion, socialization, and neuropsychomotor and cognitive development in these children. However, first-time parents with little prior experience with children and their developmental processes may become inattentive or overly anxious during this phase.

The difficulty in knowing how to proceed with a diagnosis after detecting any abnormality can also increase family stress. This study aims to conduct a document analysis of intersectoral articulation strategies between the health and education sectors within the context of the School Health Program (PSE).

The focus is on early identification and care of children with ASD in early childhood education in the municipal network of Maricá, RJ. We analyzed publicly available information on the website and documents from the municipality of Maricá. Our goal was to systematize knowledge about the pathway for early diagnosis and intervention of ASD in the municipality.

Based on this, we aimed to develop a guide and make it freely available in the educational network. This guide will serve as an instrument and provide parents and guardians of children with ASD, educators, and health professionals with systematized guidance information. It will explain the interface between the education and health sectors and promote comprehensive, collaborative care. We believe the guide will facilitate access and improve intersectoral care for children with ASD in the municipal public network.

Keywords: Autism Spectrum Disorder, Early Childhood Education, School Health Program, Early Intervention.

1. Introdução

1.1. Apresentação

Ao longo da minha trajetória acadêmica e profissional na educação básica, desenvolvi um interesse particular pela educação inclusiva, buscando compreender melhor as diferenças e aprimorar minha prática pedagógica. Minha formação iniciou-se no Curso Normal, seguida da graduação em Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), além de especializações voltadas ao desenvolvimento e à aprendizagem de pessoas com deficiência. Essa caminhada formativa, aliada à minha atuação como Orientadora Educacional na rede municipal de Maricá ao longo de 17 anos, despertou inquietações relacionadas aos desafios cotidianos da inclusão escolar, especialmente no atendimento a crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

Nesse contexto, o presente estudo insere-se na interface entre educação e saúde, tendo como foco o percurso de atendimento e o diagnóstico precoce do TEA na educação infantil. Considerando o aumento significativo de casos e a complexidade do processo de identificação e intervenção, emerge como problema de pesquisa a seguinte questão: como se organiza, no município de Maricá, a articulação entre os setores de educação e saúde no atendimento às crianças com TEA, especialmente no que se refere ao diagnóstico precoce e às intervenções iniciais?

A relevância deste estudo justifica-se pela necessidade de fortalecer a articulação intersetorial entre educação e saúde, garantindo um atendimento mais ágil, integrado e eficaz às crianças com TEA e suas famílias. Apesar dos avanços nas políticas públicas e da ampliação da rede de serviços no município, ainda se observam lacunas no acesso à informação, na organização dos fluxos de atendimento e na comunicação entre os setores envolvidos, o que pode impactar diretamente o desenvolvimento e a inclusão dessas crianças.

Diante disso, o objetivo geral desta pesquisa é analisar as estratégias de articulação intersetorial entre educação e saúde no contexto do Programa Saúde na Escola (PSE), com foco na identificação precoce e no atendimento às crianças com

TEA na educação infantil da rede municipal de Maricá. Como objetivo específico busca-se: mapear o percurso de atendimento desde a suspeita até o diagnóstico; identificar os principais serviços e fluxos existentes no município e sistematizar essas informações na forma de um guia que auxilie famílias, educadores e profissionais da saúde.

Para alcançar tais objetivos, foi realizada uma análise documental, tendo como base documentos oficiais disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Maricá, legislações nacionais e políticas públicas, como o Plano Nacional de Educação (PNE), o Plano Municipal de Educação (PME), documentos do Programa Saúde na Escola (PSE) e materiais orientadores da área da saúde e educação. A análise desses documentos permitiu compreender como as diretrizes normativas se materializam no contexto local e identificar possíveis lacunas na articulação intersetorial.

Assim, esta pesquisa busca não apenas compreender o percurso de atendimento às crianças com TEA no município, mas também contribuir com a construção de um instrumento prático que favoreça o acesso à informação e fortaleça a integração entre educação e saúde, promovendo um atendimento mais humanizado, eficiente e inclusivo.

1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ

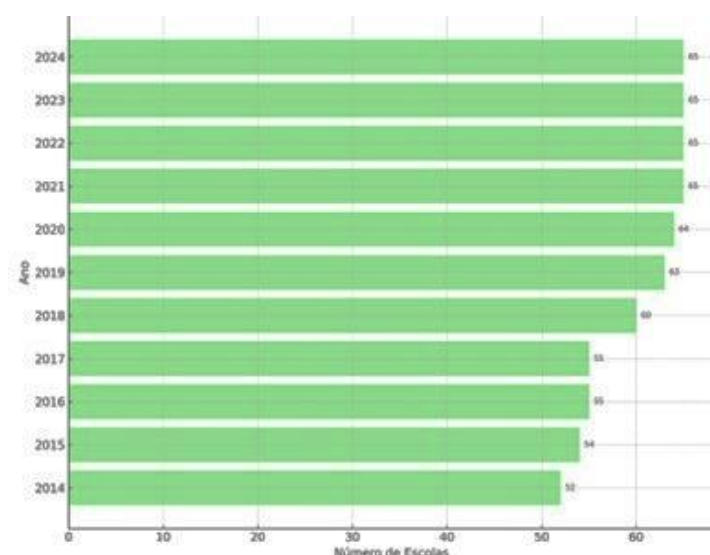
O município de Maricá está localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, distante 60 km da capital fluminense (Portal de Maricá), com divisão territorial em quatro distritos: Maricá (sede), Ponta Negra, Itaipuaçu e Inoã. A história da cidade de Maricá é marcada por transformações econômicas e sociais ocorridas ao longo dos séculos, desde sua criação como vila em 1832 até os dias atuais. Atualmente, a cidade vem passando por mudanças intensas e significativas, em decorrência da descoberta e exploração de recursos naturais, crescimento populacional, novas políticas públicas e crescente desenvolvimento local.

Macedo (2024) afirma que a ascensão econômica da cidade é impulsionada pelos royalties do petróleo que têm sido utilizados para investir em diversos setores, incluindo infraestrutura, saúde, educação e projetos sociais. E descreve que o

crescimento econômico da cidade de Maricá se dá pelo fruto de uma série de políticas públicas implementadas estrategicamente, como os programas sociais. Em relação à população, conforme os dados do IBGE, divulgados no Censo de 2022, o município registrou uma população de 197.277 habitantes, com uma estimativa de 211.986 para o ano de 2024.

A fim de atender a demanda demográfica, a rede de ensino de Maricá foi ampliada no período entre 2014 e 2024 segundo os dados do Censo Escolar 2024, passando de 44 para 65 unidades. Ademais, dados divulgados pela Secretaria Municipal de Educação de Maricá no início do ano letivo de 2025 informam que a cidade atualmente conta com um total de 75 escolas (Gráfico 1).

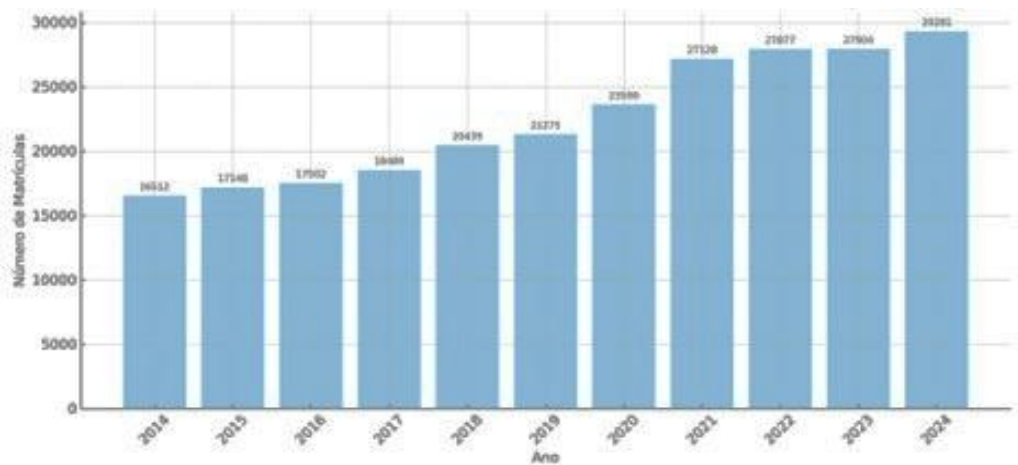
Gráfico 1: Número de escolas da rede municipal de Maricá (2014-2024)



Fonte: A autora, 2025. A partir de dados disponíveis no site INEP dados do Censo Escolar 2024.

Essa ampliação na quantidade de vagas disponíveis e no aumento da população pode ser refletida no aumento do número de matrículas na rede municipal de ensino (Gráfico 2).

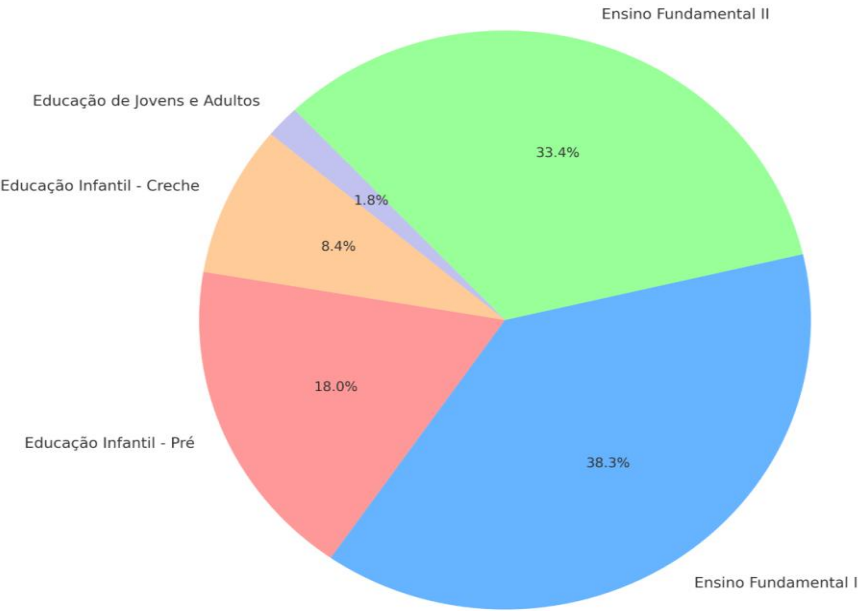
Gráfico 2: Crescimento do número de matrículas na rede pública de ensino de Maricá (2014-2024)



Fonte: A autora, 2025. A partir de dados disponíveis no site INEP dados do Censo Escolar 2024.

As vagas de matrículas são distribuídas nos diferentes segmentos educacionais conforme dados do Censo Escolar do INEP, de 2024, apresentado no Gráfico 3.

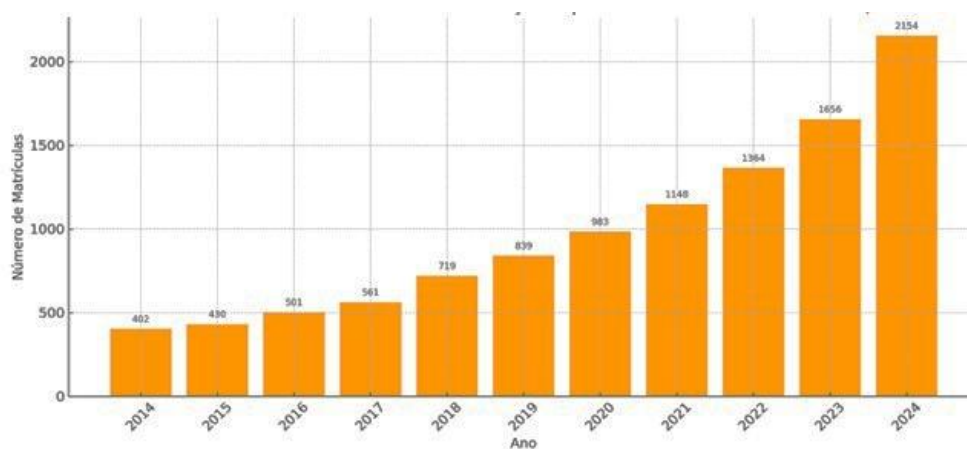
Gráfico 3: Distribuição de matrículas na Educação Especial na rede pública de ensino de Maricá (2014-2024)



Fonte: A autora, 2025. A partir de dados disponíveis no site INEP dados do Censo Escolar 2024.

Adicionalmente, houve uma expansão das matrículas da Educação Especial na rede municipal de Maricá, e destes matriculados, quase 58% destes são TEA.

Gráfico 4: Crescimento do número de matrículas na Educação Especial da rede pública de ensino de Maricá (2014-2024)



Fonte: A autora, 2025. A partir de dados disponíveis no site INEP dados do Censo Escolar 2024.

1.3. EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Este segmento escolar é essencial para o desenvolvimento global do aluno, pois possibilita o fortalecimento de competências fundamentais para a convivência, a socialização e a aprendizagem. A oferta de estímulos estruturados e objetivos bem definidos favorece o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como empatia, cooperação, autonomia e respeito às diferenças. Segundo a BNCC (2017), a entrada na creche ou na pré-escola representa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças de seus vínculos afetivos familiares para que possam se incorporar a um contexto estruturado de socialização.

O desenvolvimento infantil pode ser definido como um processo multidimensional e integral, que engloba o crescimento físico, a maturação neurológica, o desenvolvimento comportamental, sensorial, cognitivo e de linguagem, assim como as relações socioafetivas. E tem como efeito tornar a criança capaz de responder às suas necessidades e as do seu meio, considerando seu contexto de vida (Brasil, 2016, p. 12).

Partindo da compreensão de que a criança se desenvolve de forma integral e em constante troca com o mundo ao seu redor, a Educação Infantil deve ser um

espaço acolhedor, onde cada criança tenha seu tempo, sua história e suas necessidades respeitadas. Criando oportunidades de viver experiências significativas, que favoreçam a escuta, o afeto, a construção de vínculos, o lugar de descobertas, onde habilidades como a convivência, a comunicação e o aprender ganham sentido no encontro com o outro e no respeito às singularidades de cada infância. Neste contexto de intensas experiências vivenciadas na educação infantil, o período de escolarização tem um papel crucial no desenvolvimento humano. Ele é essencial para a aquisição de conhecimentos, o domínio de habilidades e o estabelecimento de relações interpessoais. Construindo bases sólidas para ampliação de conhecimentos e habilidades que acompanharão o indivíduo por todo o seu trajeto educacional.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) vigente orienta as práticas pedagógicas para esta etapa da escolarização, estabelecendo objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que visam garantir o desenvolvimento integral. Ao promover uma educação mais equitativa e inclusiva, a BNCC contribui para a formação de cidadãos críticos, criativos e engajados com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. (BNCC, 2017)

A Educação Infantil é um direito assegurado às crianças brasileiras pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei 9394/96). A importância da Educação Infantil é reconhecida em documentos oficiais do Ministério da Educação, tais como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) e o Plano Nacional de Educação (PNE), que estabelecem diretrizes e princípios para essa etapa da educação básica. Nesse sentido, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (DCNEB), a Educação Infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos de idade, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Este segmento educacional deve ser um espaço privilegiado para a promoção do desenvolvimento neuropsicomotor, pois as interações coletivas e as brincadeiras, caracterizadas como eixo estruturante das práticas pedagógicas, permitem que os professores percebam sinais de desenvolvimento atípico, muitas vezes sutis. Assim, a educação infantil transcende a função de garantir acesso ao ensino formal e assume um compromisso ético e social de promover a equidade, respeito às diversidades e identificação precoce de necessidades específicas que impactam o desenvolvimento humano e a inclusão escolar.

Em 2024, a Lei nº 14.880 instituiu a Política Nacional de Atendimento Educacional Especializado às Crianças de Zero a Três anos (atenção precoce) e determinou prioridade de atendimento às crianças da educação infantil, com sinais de alerta para o desenvolvimento, apoiadas pela educação especial. A legislação reforça a necessidade de garantir o conjunto de apoios, serviços e recursos através de esforços intersetoriais adequados para o atendimento pleno às crianças e suas famílias. A lei representa um avanço significativo para a efetivação do direito à inclusão e ao desenvolvimento integral na primeira infância, especialmente para crianças com deficiência, com TEA, altas habilidades ou em situação de risco, pois oferece apoios e recursos necessários para atender às necessidades das crianças. (BRASIL, 2016)

1.4. O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)

Historicamente, as primeiras descrições do autismo remontam a Eugen Bleuler (1908) e Leo Kanner (1943), que lançaram as bases para a investigação e a primeira descrição clínica detalhada do autismo infantil. A descrição por Kanner (1943) destacava características marcantes, tais como a dificuldade de socialização e a preservação da rotina. A contribuição da psiquiatra russa Grunya Sukhareva, já em 1920, em relação às descrições de padrões comportamentais em crianças, tais como dificuldades de socialização, sensibilidade sensorial e comportamentos repetitivos, antecipou em várias décadas conceitos que só seriam amplamente discutidos posteriormente. Embora pouco difundidas à época, suas descrições reforçaram a ideia de que o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento com expressões diversas. Complementando esse percurso histórico, Hans Asperger, em

1944, descreveu um grupo de crianças com habilidades verbais preservadas, interesses restritos e formas peculiares de interação social, um perfil que ampliou a compreensão sobre autismo. Embora os diagnósticos tenham se transformado ao longo do tempo, as contribuições desses autores foram essenciais para consolidar a noção atual de espectro e heterogeneidade das manifestações do TEA.

Do ponto de vista clínico, o TEA configura-se como um transtorno do neurodesenvolvimento que se manifesta desde os primeiros anos de vida, acarretando prejuízos em diversas áreas do desenvolvimento (DSM-5, 2014). É caracterizado por um conjunto de alterações neurológicas com manifestações comportamentais variadas, que impactam o desenvolvimento e as conexões das áreas cerebrais, resultando em um funcionamento neurotípico. As características centrais do transtorno incluem dificuldades na comunicação e interação social recíproca, comportamentos restritos e repetitivos, e o comprometimento no funcionamento geral da pessoa. Estas surgem nos primeiros anos de vida, e frequentemente impactam a autonomia e o desenvolvimento de habilidades essenciais. significativas nas atividades de vida diária (AVD), desde as mais simples, como vestir-se, até as mais complexas, como interagir com outras crianças em atividades típicas da infância. Neste tipo de transtorno, podem também fazer parte da sintomatologia movimentos estereotipados e maneirismos, assim como padrão de inteligência variável, dificuldades na regulação emocional e sensibilidade a estímulos. Segundo Shaw e colaboradores (2022), aproximadamente 39,6% dos casos de TEA podem estar associados à comorbidades como a deficiência cognitiva.

Por se tratar de um transtorno do neurodesenvolvimento, cada pessoa autista terá um desenvolvimento único, com ritmos de aprendizagem e desenvolvimento distintos dos indivíduos que não estão no espectro. Essas diferenças podem ser valiosas para nossa convivência em sociedade se olharmos além das limitações e dificuldades, reconhecendo a pessoa como um ser humano único com potencial e o direito de participação e inclusão.

De modo geral, indivíduos com TEA acabam influenciando na dinâmica estrutural e funcional da família, cabendo salientar a importância da orientação aos pais em relação às vantagens e desvantagens relacionadas a cada tratamento, pois cada autista é único e o que pode funcionar para um pode não ter êxito para outro. Outros fatores relevantes a serem

respeitados são os limites e os recursos financeiros de cada família. (Onzi e Gomes, 2015)

Sua etiologia ainda é desconhecida; entretanto, a tendência atual é considerá-la como uma síndrome de origem multicausal envolvendo fatores genéticos, neurológicos e sociais da criança. Segundo Shaw e colaboradores (2022), em trabalho de revisão sistemática, o TEA foi 3,4 vezes mais prevalente entre meninos (49,2) do que entre as meninas (14,3).

Dados epidemiológicos dos Estados Unidos da América (Tabela 1) apontam para um aumento progressivo dos casos de diagnóstico do TEA em crianças de 1 a 8 anos ao longo dos últimos anos, afirmam que atualmente, uma a cada 31 crianças é diagnosticada com TEA (CDC, 2022; Shaw et al., 2022). Este aumento observado na incidência do TEA é multifatorial, sendo resultado de uma combinação que inclui a ampliação e refinamento dos critérios diagnósticos no manual DSM-5 (mais abrangente que a DSM-IV), a maior conscientização pública e profissional sobre o tema, melhorias nas ferramentas de rastreio e diagnóstico, a melhor formação e treinamento de profissionais especializados, e a diminuição da subnotificação ao longo do tempo, que torna mais visíveis casos que antes eram difíceis de identificar.

Tabela 1: Dados epidemiológicos da prevalência de TEA nos Estados Unidos

ANO DO LEVANTAMENTO	ANO DE NASCIMENTO	NÚMERO DE RELATÓRIOS POR SITE ADDM	Prevalência combinada por 1.000 crianças (variação entre os locais do ADDM)	Isso representa cerca de 1 em cada X crianças
2022	2014	16	32.2 (9.7 - 53.1)	1 in 31
2020	2012	11	27.6 (23.1-44.9)	1 in 36
2018	2010	11	23.0 (16.5-38.9)	1 in 44
2016	2008	11	18.5 (18.0-19.1)	1 in 54
2014	2006	11	16.8 (13.1-29.3)	1 in 59
2012	2004	11	14.5 (8.2-24.6)	1 in 69
2010	2002	11	14.7 (5.7-21.9)	1 in 68
2008	2000	14	11.3 (4.8-21.2)	1 in 88
2006	1998	11	9.0 (4.2-12.1)	1 in 110
2004	1996	8	8.0 (4.6-9.8)	1 in 125
2002	1994	14	6.6 (3.3-10.6)	1 in 150
2000	1992	6	6.7 (4.5-9.9)	1 in 150

Fonte: Dados estatísticos do CDC (<https://www.cdc.gov/autism/data-research/index.html>) sobre a prevalência do TEA ao longo dos anos. ADDM = Monitoramento de Autismo e Deficiências de Desenvolvimento (do inglês, Autism and Developmental Disabilities Monitoring).

A apresentação do TEA varia de formas leves, por vezes sutis, até quadros graves com comprometimentos significativos (Schmidt, 2017, p. 222). Atualmente, o DSM-5 classifica o transtorno em três categorias de acordo com o nível de suporte necessário, que auxiliam na descrição dos sintomas, os quais podem variar conforme o contexto e ao longo do tempo. As categorias são: nível 3 (necessita de apoio muito substancial), nível 2 (necessita de apoio considerável) e nível 1 (necessita de apoio). O diagnóstico é essencialmente clínico, baseado na observação do comportamento e na identificação de atrasos no desenvolvimento. Independente do nível de gravidade, é fundamental que os cuidados sejam individualizados e atendam às necessidades específicas de cada indivíduo.

No que se refere à legislação específica, temos a Lei nº 12.764/12 (Lei Berenice Piana), primeira legislação federal a garantir direitos às pessoas com TEA, assegurou o direito ao acesso a serviços especializados, incluindo diagnóstico, tratamento e acompanhamento multidisciplinar, além de tratamentos terapêuticos e medicamentos, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), visando atender às suas necessidades específicas e promover saúde e qualidade de vida. A Lei nº 13.977/2020 (Lei Romeo Mion) alterou a Lei Berenice Piana e a Lei nº 9.265/1996, e além de dar outras providências, instituiu a Carteira de Identificação da Pessoa com TEA (Ciptea) em território nacional.

No campo educacional, a inclusão de estudantes com TEA é tema recorrente nas discussões acadêmicas e nas políticas públicas. A educação inclusiva também é assegurada pela Lei nº 13.146/15, que garante o direito constitucional à educação da pessoa com deficiência em todos os níveis de ensino, ao longo da vida, com o objetivo de promover a inclusão social. O Relatório Técnico Científico, “Nortear: Orientações para o Atendimento Educacional ao Estudante com Transtorno de Espectro Autista” (parecer CNE/CP nº 50/2023), baseado em práticas validadas cientificamente para a educação de alunos com TEA, estabeleceu diretrizes federais para a inclusão escolar. O documento orienta o atendimento especializado, a individualização pedagógica, a formação docente, bem como a importância do Plano Educacional Individualizado (PEI) e da comunicação entre a escola e a família para o desenvolvimento integral do aluno. O Nortear apresenta contribuições pioneiras e visa unificar as práticas pedagógicas no Brasil, garantindo equidade e o pleno desenvolvimento dos estudantes com autismo.

1.4.1 DIAGNÓSTICO E A INTERVENÇÃO PRECOCE NO TEA

O diagnóstico do TEA na primeira infância é um campo de intensa pesquisa e debate, refletindo avanços científicos e desafios práticos no contexto da saúde pública e da educação inclusiva no Brasil. A literatura internacional e nacional converge sobre a importância da identificação e intervenção precoces como fatores decisivos para o desenvolvimento e a qualidade de vida das crianças com TEA e suas famílias. Quirino e colaboradores (2025), afirmam que:

A identificação precoce dos sinais de transtorno do espectro autista (TEA) antes dos 3 anos é essencial para direcionar as crianças a intervenções que podem impactar positivamente seu desenvolvimento, mas isso depende da eficácia da triagem, que requer o uso de instrumentos padronizados.

A Sociedade Brasileira de Pediatria, em seu manual orientador (2019, p. 4), destaca que para um diagnóstico adequado é necessária uma equipe multidisciplinar experiente e informações coletadas por todos que fazem parte da rotina e convívio da criança, principalmente os familiares, os cuidadores e os professores na escola. O diagnóstico do TEA envolve um processo complexo e requer uma avaliação cuidadosa e individualizada com avaliação completa e uso de escalas validadas, uma vez que cada criança é única e pode apresentar uma variedade de sintomas e características específicas (SBP, 2019, p. 4). Os critérios diagnósticos são rigorosamente estabelecidos pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) e também pela Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), e devem ser baseados principalmente no quadro clínico da criança, com critérios estabelecidos no DSM V (APA, 2013).

O desenvolvimento infantil é um processo multidimensional, envolvendo aspectos físicos, cognitivos, emocionais e sociais, e os marcos do desenvolvimento funcionam como parâmetros para avaliar se a criança está evoluindo conforme o esperado. Embora haja variações individuais, existem limites de segurança para cada marco e, por isso, atrasos significativos devem ser considerados sinais de alerta, despertando atenção de familiares e a observação dos profissionais de saúde e educação. Adicionalmente, o emprego de instrumentos validados de

rastreio e triagem é essencial para encaminhar a criança a uma avaliação especializada e garantir intervenções precoces.

Entre os sinais precoces que podem ser observados nos primeiros meses de vida, estão: pouco contato visual, ausência de choro em solidariedade, desatenção à voz humana e pouca resposta ao nome, preferência por objetos a rostos, ausência de sons vocais e sorriso social, ausência de gestos sociais e dificuldades de atenção compartilhada, além de atraso motor e movimentos estereotipados e repetitivos. A identificação precoce dos sinais é fundamental, pois permite o início imediato de intervenções que potencializam a neuroplasticidade e favorecem o desenvolvimento de habilidades adaptativas e sociais. Desta forma, salienta-se que a identificação de atrasos no desenvolvimento, bem como a definição do diagnóstico precoce, idealmente antes dos três anos de idade, maximiza os resultados das intervenções, otimizando o aprendizado, prevenindo efeitos secundários negativos, melhorando as habilidades funcionais e a qualidade de vida e se constituem como fatores determinantes para a minimização de prejuízos decorrentes do TEA na vida futura da criança (Rogers e Vismara, 2014; Quirino et al., 2025).

O processo de investigação clínica e o recebimento do diagnóstico de TEA podem desencadear incertezas, medo, dúvida, frustração e representam desafios significativos para as famílias, pois interferem na rotina diária, na readaptação de papéis familiares e nos âmbitos ocupacional e financeiro, bem como nas relações familiares. O diagnóstico também permite usufruir dos direitos, adaptações e garantias asseguradas por lei (Pinto et al., 2016, p. 3). Nesse contexto, o núcleo familiar, primeiro espaço de vivências, estímulos, interações e aprendizagens, constitui uma fonte crucial de informações, pois frequentemente identifica as primeiras alterações, disfunções ou dificuldades de interação, as quais podem ser levadas ao conhecimento do pediatra. Esse núcleo também é essencial para a compreensão da trajetória realizada da suspeita inicial até o diagnóstico e as condutas subsequentes, a fim de fazer o diagnóstico da efetividade dos instrumentos públicos e privados utilizados para estas ações.

Estudos apontam que, em busca do diagnóstico correto, famílias chegam a procurar até cinco profissionais, até que suas queixas sejam validadas e que o diagnóstico de TEA seja fechado. A não valorização das

percepções dos pais sobre o desenvolvimento do filho, por parte dos pediatras, pode contribuir para o atraso do diagnóstico de TEA (Ribeiro et al. 2017 apud Iria, 2024).

Apesar do diagnóstico de TEA poder ser implementado com confiança até os dois anos de idade, conforme orienta a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP, 2019, p. 8), a média de idade para o diagnóstico no Brasil é de seis anos. Com o intuito de enfrentar esse desafio foi sancionada a Lei nº 13.438 em 2017, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e tornou obrigatória a adoção pelo SUS de protocolo com padrões para avaliação de riscos para o desenvolvimento psíquico das crianças. Desta forma, o MS adotou a aplicação de um instrumento de avaliação formal do neurodesenvolvimento em todas as crianças nos seus primeiros dezoito meses de vida, através da Caderneta de Vacinação, em razão de seu amplo alcance. Essa padronização no instrumento de avaliação (teste MChat) propicia a identificação precoce de possíveis problemas e permite o encaminhamento à intervenção adequada, mesmo sem a confirmação do diagnóstico. Quirino e colaboradores (2025) defendem que:

A intervenção precoce tem se mostrado um dos fatores mais determinantes para melhorar os desfechos no desenvolvimento de crianças diagnosticadas com TEA. Os estudos apontam que a identificação e o início do tratamento em fases iniciais da vida favorecem ganhos significativos em áreas como comunicação, interação social e habilidades adaptativas.

No cenário mundial, o TEA representa um dos principais desafios de saúde pública e educação inclusiva. E demanda profissionais especializados na saúde e na educação e a participação ativa das famílias. O diagnóstico precoce, aliado à intervenção intensiva e personalizado, constitui o caminho mais promissor de acordo com a literatura no campo do autismo. O aumento no número de diagnósticos reflete não apenas maior conscientização e aprimoramento dos critérios clínicos, mas também evidencia a necessidade de políticas públicas robustas para garantir o acesso ao diagnóstico precoce, às intervenções terapêuticas e à inclusão escolar efetiva.

Segundo Marçal e colaboradores (2023), o acompanhamento de crianças que estejam dentro do espectro desde a primeira infância é importante para possibilitar maior inclusão e superação das características prejudiciais ao seu desenvolvimento motor e cognitivo. A intervenção precoce é fundamental para pacientes com TEA,

devendo ser iniciada quando há grandes suspeitas do quadro ou logo quando se comprove o diagnóstico (Viana et al., 2020). Essa demanda de diagnóstico e intervenção precoce reforça a relevância de estudos que versam sobre a criação de estratégias e ferramentas que disseminem informações de acesso aos serviços de educação e saúde para as famílias de crianças com o TEA.

Intervenções precoces viabilizam para as crianças as condições necessárias para o desenvolvimento de habilidades em diferentes áreas, estimulando a neuroplasticidade e a aquisição de repertórios comportamentais cruciais para a criança se comunicar e interagir ao longo de seu desenvolvimento (Moraes et al., 2023). Essa perspectiva reforça a importância de intervenções que visem minimizar dificuldades e promover a independência na vida adulta. Quanto mais precoce a detecção das alterações e início da intervenção, maior a capacidade de organização neural através da neuroplasticidade. Além disso, a estimulação precoce aproveita o período crítico determinado pelas janelas de oportunidades no cérebro da criança e estimula a formação e organização das circuitarias neurais (SBP, 2019, p. 19). Enquanto o diagnóstico e intervenções tardios, em crianças com TEA, causam prejuízos no seu desenvolvimento global (SBP, 2019, p. 4). Ao compreendermos a profundidade de seu impacto, reconhecemos a importância de priorizar e expandir o acesso a essas intervenções, garantindo que cada criança tenha a oportunidade de alcançar seu pleno potencial e construir um futuro promissor.

A intervenção precoce, que deve ser iniciada tão logo haja suspeita ou imediatamente após o diagnóstico por uma equipe interdisciplinar, é considerada padrão-ouro de tratamento para o TEA, de acordo com o manual orientador da Sociedade Brasileira de Pediatria (2019, p. 16). Identificação e tratamento precoce são elementos imprescindíveis para o progresso na aprendizagem, linguagem e habilidades. A intervenção consiste em um conjunto de modalidades terapêuticas que visam aumentar o potencial do desenvolvimento social e de comunicação da criança, proteger o funcionamento intelectual reduzindo danos, melhorar a qualidade de vida e dirigir competências para autonomia para que o potencial de aprendizagem e autonomia seja maximizado, além de diminuir as angústias da família e os gastos com terapias sem base de evidência científica (Gomes e Sousa, 2023). Segundo Onzi e Gomes (2015), quanto mais cedo a criança for diagnosticada e iniciar o tratamento, maiores serão as possibilidades de desenvolvimento dentro

de suas capacidades físicas e mentais. Considerando a heterogeneidade do espectro, a personalização das estratégias é fundamental, especialmente quando iniciadas nos primeiros anos de vida (Castilho et al., 2018; Viana et al., 2023).

No entanto, o acesso efetivo a diagnóstico e atendimento multiprofissional ainda é um desafio em muitos contextos municipais brasileiros, especialmente em cidades que vivenciam transformações rápidas em sua estrutura social e de serviços. A importância da articulação entre saúde e educação nesta etapa de diagnóstico e intervenção deve-se ao fato de que professores e profissionais da atenção básica estão em posição privilegiada para identificar sinais precoces e encaminhar para avaliação. Além disso, o TEA impõe demandas crescentes ao sistema público de saúde e de educação. Consequentemente há a necessidade de equipes multidisciplinares, adaptações curriculares, formação continuada de professores e acesso a recursos terapêuticos especializados, o que exige investimentos contínuos e planejamento intersetorial.

1.4.2. DESAFIOS DO DIAGNÓSTICO PRECOCE

Entre os principais desafios encontrados para o diagnóstico precoce, estão o número reduzido de profissionais no SUS para assegurar o atendimento e diagnóstico destas crianças, o desconhecimento teórico e a falta de qualificação contínua que dificultam a identificação precoce, especialmente em contextos de atenção primária (Unidade Básica de Saúde – UBS). A literatura cita a insuficiente capacitação dos profissionais de saúde e educação, que muitas vezes não reconhecem sinais iniciais do TEA ou não utilizam instrumentos padronizados de triagem, entre os principais obstáculos identificados na literatura.

O diagnóstico precoce ainda enfrenta desafios, principalmente, em crianças pequenas, cujos atrasos no desenvolvimento muitas vezes só se tornam aparentes em contextos sociais além do ambiente familiar. Portanto, uma triagem adequada viabiliza o diagnóstico precoce e favorece um manejo eficaz, melhorando o desenvolvimento e a qualidade de vida. (Quirino et al., 2025)

Muitas vezes o diagnóstico é afetado pela falta de preparo dos profissionais de saúde e da educação, o que resulta em sucessivas buscas por orientação em diferentes serviços e atraso no diagnóstico/intervenção adequada. Essa

fragmentação entre as áreas da saúde e educação revela a carência de práticas formativas e de políticas de atenção integradas, que possam reduzir o percurso desgastante enfrentado pelas famílias e garantir respostas mais ágeis e coordenadas às necessidades das crianças com TEA (Romeu & Rossit, 2022; Rossit et al., 2021). Diante desse cenário, é essencial que os profissionais da saúde e da educação estejam atentos ao impacto emocional que o processo de diagnóstico provoca nas famílias, oferecendo acolhimento empático, informações claras e orientações sobre serviços e recursos disponíveis.

Fatores socioeconômicos, como baixa renda e desigualdade social, agravam as dificuldades de acesso ao diagnóstico e às terapias, comprometendo o desenvolvimento e a inclusão. Rosa et al. (2025) destacam que as barreiras estruturais e as longas filas de espera nos serviços de saúde retardam não só o acesso ao diagnóstico precoce e exames complementares, mas também ao tratamento e suporte terapêutico necessários, especialmente entre populações de baixa renda.

O impacto financeiro do TEA nas famílias é significativo e multifacetado, dificultando o orçamento familiar. Em muitos casos as famílias também apresentam impacto social, emocional e alto nível de estresse, pois se vêem diante do desafio de ajustar seus planos e expectativas futuras às limitações da condição, além da necessidade de intensa dedicação aos cuidados cotidianos, adaptando suas rotinas e ambientes para atender às demandas específicas de seus filhos (Monhol, 2021).

No Brasil, o impacto financeiro se estende à esfera pública, sobrecarregando os sistemas de saúde (SUS) e educação com a demanda por serviços especializados e recursos adicionais para atender às necessidades das pessoas com TEA que necessitam de investimentos significativos, destacando a urgência de intervenções precoces e eficazes. Nesse contexto, as políticas públicas que priorizam o diagnóstico, intervenções precoces e o desenvolvimento de políticas educacionais inclusivas não apenas promovem a sustentabilidade dos sistemas públicos, mas também favorecem a inclusão de forma mais equitativa (Silva, Souza e Silva, 2024). O poder público, em todas as suas esferas de governo, juntamente com família e escola, deve se responsabilizar pelo processo de inclusão educacional do aluno autista.

O diagnóstico precoce do TEA permite melhor prognóstico à promoção do desenvolvimento e da inclusão de crianças autistas. Isto se deve à implementação de intervenções adaptadas às necessidades individuais. Apesar de a legislação brasileira assegurar o atendimento especializado pelo SUS (Lei Berenice Piana nº 12.764/2012), na prática, a carência de profissionais ou de prática baseada em evidências pode retardar o desenvolvimento, aquisições e a independência desta criança.

Intervenções precoces viabilizam para as crianças as condições necessárias para o desenvolvimento de habilidades em diferentes áreas, estimulando a neuroplasticidade e a aquisição de repertórios comportamentais cruciais para a criança se comunicar e interagir ao longo de seu desenvolvimento. (Moraes et al., 2023).

1.5. O DIREITO À INCLUSÃO ESCOLAR

A inclusão educacional das pessoas com deficiência (PCD) é um direito humano fundamental que visa garantir a equidade no acesso à educação para todas as crianças, independente de suas diferenças, sejam por condições físicas, intelectuais ou sociais. A educação inclusiva é assegurada pela Lei Brasileira de Inclusão (LBI, lei nº 13.146/2015), que garante o direito constitucional à educação da pessoa com deficiência (incluindo o TEA) em todos os níveis de ensino; pela Lei nº 14.880/2024, que institui a Política Nacional de AEE a Crianças 0 a 3 anos (Atenção Precoce); pelo Decreto nº 12.686/2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva; e pelo Plano Nacional de Educação (PNE, 2014).Fonseca e colaboradores (2025) descrevem que:

Entre os principais marcos normativos destacam-se: Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) – Afirma que todos têm direito à educação, sem discriminação. A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) – reconhece a necessidade de escolas inclusivas e adaptações curriculares. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006) defende a acessibilidade e a inclusão escolar.

Nesse contexto, o ambiente escolar tem como função desenvolver estratégias para o aprendizado e a interação social entre os alunos (Fonseca, de Souza, 2022). A inclusão no ambiente escolar promove a convivência e a interação, estimulando o respeito mútuo, enriquecendo o ambiente e as relações, contribuindo para um olhar

acerca do indivíduo e não sobre a deficiência. De acordo com Cintra e Brum (2023), a escola é o ambiente propício para aprender a conviver com as diferenças, pois contribui para a construção de uma sociedade igualitária. Podendo ser um espaço social capaz de impulsionar mudanças e sensibilizar as pessoas para conviver respeitosamente com as diferenças que permeiam o convívio diário (Pavesi, et al., 2023).

A proposta de educação inclusiva está fundamentada nos direitos humanos e é baseada na filosofia de reconhecer e aceitar a diversidade, especialmente na escola, um espaço de formação social e cidadã, onde são cultivadas relações de afeto, aprendizado e empatia, independentemente das diferenças individuais de cada membro. (Pavesi et al., 2023)

A Declaração de Salamanca em 1994 foi um marco importante para a inclusão e a educação e destacou a importância de garantir que os PcD tenham acesso à educação de qualidade nos sistemas de ensino regular. Suas proposições contribuíram para garantir e ampliar o direito à educação através de escolas inclusivas, com práticas pedagógicas para atender às individualidades dos alunos, incentivando a sociedade à participação no processo de planejamento e tomada de decisões, destacando a necessidade de formação inicial e continuada para professores.

Para atender às necessidades educacionais de cada aluno, o que é essencial na prática educacional inclusiva, é necessário adequar os diferentes elementos curriculares para atender as particularidades de cada indivíduo e de todos os alunos. É preciso flexibilizar o ensino, adotando estratégias diferenciadas e um planejamento rigorosamente adaptado às características únicas dos educandos. Isso porque o processo de ensino e aprendizagem deve ser sensível à diversidade de necessidades dos alunos na escola. (Pavesi et. al, 2023)

O Plano Nacional de Educação (PNE, 2014), vigente até dezembro de 2025, priorizou o acesso à educação infantil e fomentou a oferta do atendimento educacional especializado (AEE) complementar e suplementar aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades ou superdotação (AHSD), assegurando também a educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica. O Plano Municipal de Educação de Maricá (PME, 2015) referente ao decênio de

2015 a 2025, publicado no jornal oficial da cidade nº 1239 em 17 de novembro de 2021 também assegura esses direitos na Meta 4:

Universalizar, para a população de todas as faixas etárias com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais ou serviços especializados, públicos ou conveniados (PNE, 2014).

Entre as estratégias do Plano Municipal de Educação (PME, 2021), está prevista ação conjunta e articulada com a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Saúde, a fim de assegurar o direito à inclusão e a efetivação do AEE, para que o estudante e sua família tenham acesso integral aos serviços necessários, desde o diagnóstico até as intervenções pedagógicas e terapêuticas. O estímulo à participação das famílias e da sociedade no processo de inclusão é previsto como estratégia fundamental, uma vez que a atuação de ambas auxilia na identificação das necessidades, na busca por soluções e na avaliação da qualidade do atendimento ofertado.

No entanto, para que o direito à inclusão se concretize, é necessário que as estratégias saiam do papel e se traduzam em ações efetivas. Isso implica organização, planejamento e investimento de recursos públicos para garantir os recursos humanos necessários para o atendimento aos estudantes público-alvo da educação especial. O direito à inclusão, portanto, não se limita ao acesso, mas envolve a permanência, a participação e o sucesso escolar dos estudantes, exigindo o compromisso permanente do poder público, da escola, das famílias e da sociedade. A inclusão educacional enfrenta desafios, como a necessidade de ampliar o número de profissionais especializados, garantir a formação continuada¹ de toda a equipe escolar e consolidar a articulação intersetorial.

A efetivação da inclusão requer o reconhecimento e a valorização das diferenças como características enriquecedoras do processo de ensino e

¹ Entende-se por *formação inicial* aquela destinada à habilitação para o exercício da docência, realizada em cursos de nível médio (modalidade normal) ou superior (licenciaturas). Por sua vez, a *formação continuada* corresponde ao processo permanente de desenvolvimento profissional, que ocorre ao longo da carreira docente, visando à atualização, ao aperfeiçoamento e à adequação das práticas pedagógicas às demandas educacionais. No âmbito do Plano Nacional de Educação – PNE (Lei nº 13.005/2014), a formação inicial é abordada na Meta 15, enquanto a formação continuada é assegurada na Meta 16, como direito de todos os profissionais da educação básica.

aprendizagem, demandando organização e esforço coletivo. Nesse cenário brasileiro, de demanda crescente por atendimento especializado, especialmente na primeira infância, e dos múltiplos desafios impostos às famílias, aos profissionais e ao poder público, compreender o percurso de acesso ao diagnóstico e à inclusão de crianças autistas é fundamental para o aprimoramento das políticas de saúde e educação.

A educação inclusiva no Brasil ainda apresenta muitas deficiências, deixando lacunas que impactam diretamente as crianças autistas. No campo pedagógico, estratégias lúdicas e sensoriais têm se mostrado eficazes para promover o engajamento e a aprendizagem. Brincadeiras de imitação, jogos de associação de cores e formas, caixas de sensações e contação de histórias com fantoches são exemplos de práticas que estimulam a interação social, a comunicação e a regulação sensorial. Estudos, como os de Prudente e colaboradores (2025), reforçam a necessidade de pesquisas contínuas que aprofundem a compreensão sobre as abordagens multidisciplinares no tratamento do TEA, possibilitando avanços no atendimento e na qualidade de vida das pessoas autistas. A integração entre profissionais, familiares e sociedade é indispensável para a construção de uma rede de apoio eficaz e inclusiva.

No contexto do município de Maricá, observa-se o desafio adicional de garantir que o crescimento da rede de serviços acompanhe a demanda crescente por atendimento especializado. É imprescindível que o município de Maricá continue investindo na implementação das estratégias previstas no PME, monitorando e avaliando as ações, para que o direito à educação inclusiva seja efetivado de forma plena, equitativa e de qualidade para todos os estudantes.

1.6. PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)

O Programa Saúde na Escola² (PSE), do Ministério da Saúde e Ministério da Educação, foi criado em 2007 (Decreto Presidencial nº 6.286), e tem como objetivo favorecer o desenvolvimento de ações intersetoriais que fortaleçam a integração da

² O programa constitui um nível de planejamento que operacionaliza as diretrizes das políticas públicas, organizando recursos para atingir objetivos específicos (Secchi, 2020, p. 5). Na educação, os programas servem como instrumentos de aplicação de recursos baseados em metas plurianuais (Nicésio; Almeida; Conceição, 2015, p. 18).

saúde e educação, voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira, para enfrentar fragilidades e fomentar a conexão de conhecimento e experiências que promovam a melhoria da qualidade de vida.

Falar de saúde referenciando o fazer na escola e o fazer na Unidade Básica de Saúde (UBS) requer um olhar abrangente, que consiga realizar a intersecção necessária ao desenvolvimento de ações que contemplem as intencionalidades das duas áreas e que tenham como contexto a realidade dos educandos e suas possibilidades de ressignificar conhecimentos e práticas em prol da melhoria das condições de vida. (Ministério da Saúde, 2022)

A escola é um ambiente integrador que reúne saberes e vivências, que impactam tanto a esfera individual quanto a coletiva. Isso a torna um cenário ideal para fomentar iniciativas focadas na saúde, no bem-estar e na educação. Adicionalmente, o contexto escolar fortalece os vínculos e a convivência comunitária. O planejamento das ações conjuntas entre saúde e educação que sejam significativas e contribuam para a vida do estudante é um dos obstáculos da realização de práticas compartilhadas do PSE na promoção de ações de cuidado em saúde na escola.

A saúde na escola não é uma prática nova no Brasil. A ideia de intervir em comportamentos relacionados à saúde da população por meio da educação se intensificou no País na primeira metade do século passado. O discurso higienista passava a articular o binômio educação e saúde (SILVA, 2019).

Dentre os complexos temas que demandam essa articulação intersetorial, o atendimento a indivíduos com TEA representa, na atualidade, um dos principais desafios para os sistemas de saúde e educação no contexto brasileiro. Para otimizar a qualidade desse cuidado, é fundamental implementar abordagens fundamentadas no respeito à diversidade, na promoção integral da saúde e na antecipação e prevenção de atrasos no desenvolvimento infantil. Para tal, é fundamental otimizar a capacidade de observação dos profissionais. Tanto aqueles que interagem rotineiramente com as crianças em ambientes escolares e creches quanto os da Atenção Primária à Saúde (APS) devem ter essa observação como um ponto estratégico, dada a sua valiosa oportunidade de interação. A fundamentação legal e conceitual estabelecida pelo marco normativo atual, que reforça o reconhecimento

do TEA como condição de saúde e direito social assegurado pelo SUS, no qual pode-se destacar o papel estratégico da Atenção Primária à Saúde como a porta de entrada principal para a identificação precoce do TEA, alinhando-se às diretrizes nacionais e proporcionando a articulação necessária para a vigilância do desenvolvimento infantil em parceria com o ambiente escolar

A identificação precoce dos sinais do TEA exige, portanto, a elaboração colaborativa de estratégias entre as áreas de educação e saúde, em uma perspectiva intersetorial. Isso se alicerça no reconhecimento de que saúde e educação constituem direitos fundamentais e inalienáveis, garantidos a todas as crianças, em estrita conformidade com a legislação e as diretrizes das políticas públicas brasileiras de inclusão e proteção. O posicionamento estratégico da Atenção Primária demanda a estruturação de um fluxo assistencial contínuo que integre os diferentes níveis de atenção à saúde. Esta integração é vital para assegurar o cuidado integral às pessoas com TEA. Tal organização em rede, conforme previsto nas linhas de cuidado a, enfatiza a necessidade de protocolos bem coordenados e de equipes multiprofissionais articuladas, elementos essenciais que serão detalhados na proposta do guia intersetorial para o município de Maricá.

1.6.1. O PSE COMO POSSÍVEL ESTRATÉGIA PARA O DIAGNÓSTICO PRECOCE DO TEA

A promoção da saúde, no âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE), constitui um fundamento conceitual e prático essencial para o diagnóstico precoce do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) em crianças da educação infantil, especialmente na faixa etária das creches. A saúde é um interesse socialmente, nesse sentido o PSE pode colaborar para processos intersetoriais que integrem educação, saúde e comunidade em práticas contínuas e compartilhadas de cuidado.

Tal abordagem se faz importante para o TEA, ao considerar a necessidade de articulação entre saberes técnicos e contextos de vida dos sujeitos envolvidos. A intersetorialidade, embora reconhecida como eixo estruturante, precisa ser estruturada e fortalecida através de protocolos formalizados, planejamento intersetorial conjunto e de ações que representam demandas atuais do cotidiano das

escolas e unidades de saúde. A articulação entre escola e unidade de saúde é, portanto, uma importante demanda do Programa Saúde na Escola (Brasil, 2011).

Compreender a promoção da saúde no PSE como uma base para o diagnóstico precoce do TEA implica que a responsabilidade não se restrinja à identificação de casos. Pelo contrário, ela deve envolver a escola na criação de ambientes inclusivos, na reflexão sobre o desenvolvimento, no acolhimento às famílias e na ativação de redes integradas de apoio. A proposição do guia intersetorial desta forma, busca junto à educação e saúde por meio do PSE construir um espaço eficaz de vigilância do desenvolvimento, intervenção precoce e garantia de direitos, articulando organicamente as dimensões pedagógicas, clínicas e socioterritoriais do cuidado.

No contexto das políticas públicas de atenção à pessoa com TEA, destaca-se a Linha de Cuidados para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, documento orientador do Ministério da Saúde que organiza as etapas do cuidado no SUS, desde a vigilância do desenvolvimento até o acompanhamento longitudinal. Suas recomendações embasam a necessidade de fluxos articulados entre educação, Atenção Primária à Saúde e serviços especializados aspecto central desta pesquisa e da proposta de construção de um guia intersetorial para famílias. Para sintetizar essas diretrizes nacionais e evidenciar sua relação com a investigação realizada, apresenta-se a seguir um quadro com os principais eixos da Linha de Cuidado.

Quadro 1: Resumo das Recomendações da Linha de Cuidados para Pessoas com TEA

Item	Recomendações
Projeto Terapêutico Singular	Construção de cuidado personalizado, envolvendo equipes multiprofissionais, familiares e pessoas com TEA. Deve ser revisado continuamente, respeitando contextos e autonomia.
Intervenções Individualizadas	As intervenções devem ser adaptadas às necessidades, estágio e singularidades do indivíduo, com ênfase na intervenção precoce para maximizar o desenvolvimento e qualidade de vida.
Fluxo Assistivo	Organizar atendimento de Atenção Primária à Saúde como porta de entrada, com continuidade entre níveis de atenção e integração entre serviços e famílias.
Atenção Primária à Saúde (APS)	Vigilância e monitoramento do desenvolvimento infantil, uso de instrumentos validados (ex. M-CHAT-RF), atuação integrada e multiprofissional, com suporte familiar e comunitário.
Diagnóstico e Avaliação	Processo multiprofissional e biopsicossocial; foco em funcionalidade e necessidades individuais; utilização de relatos familiares, sociais e avaliações

	clínicas multipontos.
Tratamento e Acompanhamento	Intervenções com foco multidisciplinar, incluindo terapias diversas, suporte educacional e social; monitoramento contínuo e reavaliações periódicas.
Rede de Apoio e Intersetorialidade	Integração entre serviços de saúde, educação, assistência social e outros setores para cuidado integral, com envolvimento da família e desenvolvimento social da pessoa com TEA.
Apoio Familiar e Educação	Formação e apoio a familiares para manejo e estimulação da criança, incluindo aconselhamento, acolhimento psicossocial, fortalecimento dos vínculos e participação ativa no cuidado.
Uso de tecnologias	Implementação de telessaúde e tecnologias assistivas para facilitar acesso e apoio, ampliar cobertura e continuidade do cuidado em áreas remotas ou com carência de especialistas.
Atendimento em Situações Especiais	Serviços especializados para crises, emergências e instruções específicas, incluindo suporte odontológico, atenção domiciliar e acolhimento humanizado.

Fonte: A autora, 2025.

A síntese apresentada reforça que o cuidado à criança com TEA deve ser estruturado em rede, com participação ativa da família, da Atenção Primária à Saúde e dos serviços educacionais. Essa organização dialoga diretamente com os achados desta pesquisa, que evidenciam a necessidade de orientar as famílias sobre o percurso de atendimento e de fortalecer a articulação intersetorial ³ no município de Maricá. Assim, as recomendações nacionais sustentam a proposta do guia elaborado como produto educacional, que busca traduzir essas diretrizes em orientações claras para o território local.

2. OBJETIVOS DA PESQUISA

2.1. OBJETIVO GERAL

Analisar as estratégias de articulação intersetorial entre os setores de saúde e educação, no contexto do Programa Saúde na Escola (PSE), para a orientação,

³ Intersetorialidade pode ser compreendida como uma estratégia de gestão pública democrática que busca superar a fragmentação das políticas públicas por meio da articulação entre setores, da complementaridade das ações e do compartilhamento de responsabilidades, favorecendo respostas integradas às demandas sociais, especialmente na interface entre saúde e educação (Wanderley; Martinelli; Paz, 2020).

identificação precoce e o atendimento a crianças da educação infantil com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) na rede municipal de Maricá.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Avaliar as políticas, protocolos e instrumentos oficiais em níveis nacional, estadual e municipal, que orientam a Intersetorialidade entre saúde e educação no PSE, bem como no cuidado ao TEA, presentes nos documentos oficiais e normativos vigentes.
2. Identificar diretrizes e práticas locais relacionadas ao PSE e à articulação intersetorial entre saúde e educação através da análise de documentos públicos municipais de Maricá.
3. Elaborar, a partir dos achados documentais e da revisão de literatura, um guia intersetorial voltado para famílias/responsáveis, educadores e profissionais de saúde, organizando o percurso de identificação, encaminhamento e acompanhamento de crianças da Educação Infantil com sinais ou diagnóstico de TEA na rede municipal de Maricá.

3. METODOLOGIA DA PESQUISA

3.1 MÉTODO DA PESQUISA

Para pesquisar precisamos de métodos e técnicas que nos levem criteriosamente a resolver problemas. [...] é pertinente que a pesquisa científica esteja alicerçada pelo método, o que significa elucidar a capacidade de observar, selecionar e organizar cientificamente os caminhos que devem ser percorridos para que a investigação se concretize (GAIO, CARVALHO e SIMÕES, 2008: 148).

Trata-se de um estudo de revisão da literatura e análise documental, com abordagem qualitativa, que possibilita compreender de forma aprofundada os sentidos, diretrizes e lacunas presentes nos documentos oficiais que orientam as políticas públicas⁴ voltadas à atenção às crianças com Transtorno do Espectro do

⁴ Segundo Secchi (2020, p. 2), política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público. Complementarmente, Shiroma, Moraes e Evangelista (2002, p. 7) ressaltam que tais políticas expressam as contradições do projeto social do Estado e adaptam-se aos modos de formação adequados à organização do trabalho e da vida.

Autismo (TEA), com ênfase na articulação entre os setores da saúde e da educação no contexto da Educação Infantil.

O caráter documental da investigação fundamenta-se na análise de documentos normativos nacionais e municipais, orientadores e institucionais de acesso público, que divulgam serviços de atendimento e organização de secretarias de governo. A partir dessa investigação e com base nas evidências obtidas nas revisões de literatura e documental, foi elaborado um produto educacional: um guia que apresenta, de forma sistematizada, o percurso de atendimento, com o objetivo de facilitar a compreensão e a circulação dessas informações entre famílias, educadores e profissionais da rede pública municipal.

3.2. REVISÃO DE LITERATURA

A revisão da literatura foi realizada por meio da análise de artigos indexados, com período de publicação entre 2020 e 2025, presentes nas bases Scielo, Google Scholar e Portal Capes, utilizando operadores booleanos “AND” e “OR” na busca e os seguintes descritores: Transtorno do Espectro Autista, intervenção precoce, educação infantil, Programa Saúde na Escola e Educação Infantil.

Após a busca dos artigos, foi realizada a primeira triagem, eliminando os artigos em duplicidade nas bases de dados. Após esta etapa foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão listados abaixo para a seleção dos artigos.

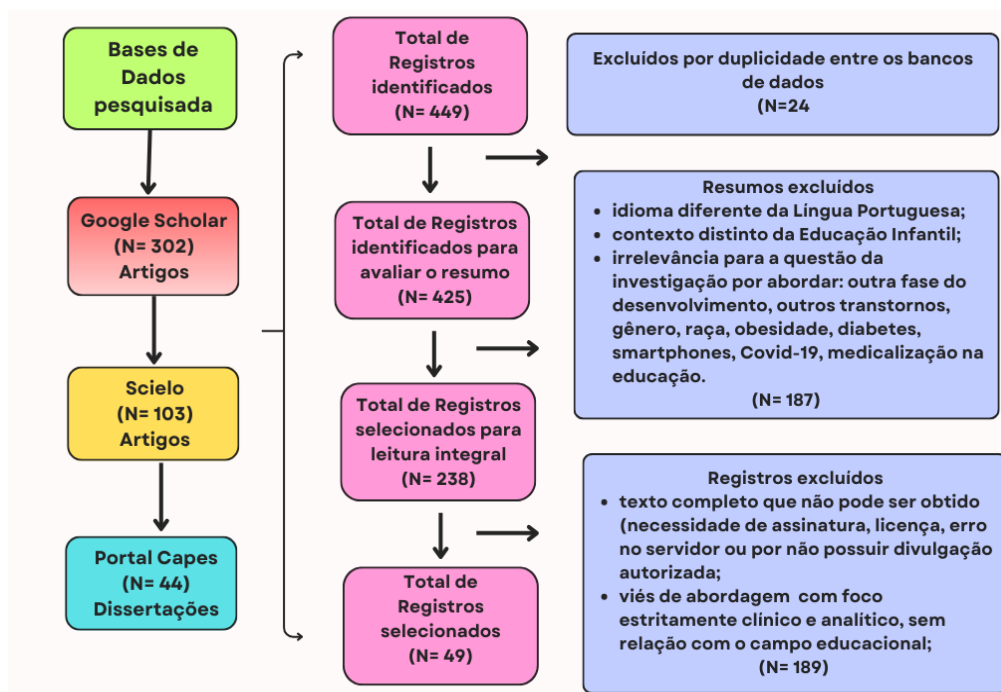
- ✓ Critério de Inclusão: artigos em português, em contexto da educação infantil, diagnóstico e intervenção precoce do TEA e suas especificidades.
- ✓ Critérios de exclusão: viés de abordagem fora do contexto educacional, texto integral não disponível gratuitamente, ausência de descrição detalhada de objetivos, metodologia de coleta e análises dos dados, resultados e conclusão.

Esse processo garantiu uma seleção de trabalhos relevantes e metodologicamente consistentes para subsidiar a pesquisa e atender as demandas necessárias para fundamentar a construção do produto educacional e alcançar os objetivos propostos. A fim de assegurar rigor metodológico, transparência e relevância científica na seleção dos materiais da revisão de literatura que fundamenta este estudo, as buscas ocorreram em bases de dados confiáveis e

foram estabelecidos critérios explícitos e sistemáticos de inclusão e exclusão dos trabalhos analisados.

3.2.1. PROCESSO DE SELEÇÃO DOS ESTUDOS

A busca por artigos publicados entre 2020 a 2025 foi concentrada nas bases de dados Scielo, Google Scholar e no Portal da Capes. Durante a busca com os descritores propostos foi encontrado um total de 449 artigos nas 3 bases de dados, sendo 302 resultados do Google Scholar, 103 do Scielo e 44 do Portal Capes. Destes, 24 artigos foram excluídos por duplicidade nas bases de dados, 187 foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão, e 189 foram excluídos segundo os critérios de exclusão. A partir da seleção utilizando os critérios de inclusão e exclusão previamente descritos, 49 artigos foram incluídos nesta revisão da literatura para compor a base analítica da pesquisa proposta (Fluxograma 1). O processo de triagem dos artigos garantiu a seleção de trabalhos relevantes e metodologicamente consistentes para subsidiar a pesquisa.



Fluxograma 1: Processo de seleção dos artigos incluídos

Fonte: A autora, 2025.

3.3. REVISÃO DOCUMENTAL

A pesquisa documental configura-se como uma estratégia metodológica fundamental para a compreensão de fenômenos educacionais e sociais, ao permitir a análise sistemática de registros oficiais, normativos e institucionais produzidos no contexto das políticas públicas. Conforme apontam Lüdke e André (1986), os documentos constituem fontes relevantes de informação em pesquisas qualitativas por apresentarem caráter duradouro e amplo potencial analítico. Pois podem ser revisitados ao longo do processo investigativo, permitindo múltiplas leituras e interpretações, contribuindo, desta forma, para a consistência das análises.

A análise documental foi fundamentada em autores como Gil (2008) e Cellard (2008) que indicam etapas sistemáticas para garantir o rigor na interpretação dos dados e evidenciar as relações entre documentos e objetivos da pesquisa. Para Gil (2008) a pesquisa documental é caracterizada pela pesquisa de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. Cellard (2008, p.296) afirma ser impossível transformar um documento, precisando aceitá-lo tal como ele se apresenta incompleto, parcial ou impreciso que seja.

Os documentos foram examinados acerca dos objetivos do estudo, buscando verificar como se articulam políticas públicas, fluxos institucionais e o acesso das famílias à rede de atendimento. O procedimento seguiu as etapas de análise preliminares recomendadas por Cellard (2008), que afirma que:

Uma boa compreensão do contexto é, pois, crucial, em todas as etapas de uma pesquisa documental, tanto no momento da elaboração de um problema, da escolha das pistas a seguir para descobrir as principais bases de arquivos, quanto no momento da análise propriamente dita. Esse conhecimento deve também ser global, pois nunca se pode saber de antemão quais são os elementos da vida social que será útil conhecer, quando chegar o momento de formular interpretações e explicações (CELLARD, 2008, p. 300).

Essa orientação contextual guiou, portanto, todas as etapas da revisão documental, desde a identificação das fontes até a categorização temática dos achados. Por fim, os achados foram sistematizados e analisados de acordo com os critérios explicados na Tabela 2 abaixo, são eles: o contexto, os autores, a

autenticidade e confiabilidade da natureza do texto, a estrutura lógica e os conceitos-chave.

Quadro 2: Critérios para Análise Preliminar

O contexto	Documentos situados no contexto municipal, relacionados às políticas públicas de atendimento ao TEA.
Os autores	Produzido por órgãos públicos, instituições de saúde/educação, pesquisa oficial e acadêmica.
A autenticidade, a confiabilidade e a natureza do texto.	Documentos oficiais divulgados no site da Prefeitura vinculados a Secretaria de governo como Assistência Social e Inclusão. Disponibilizados também em reunião oficial de equipe da Secretaria de Educação.
Estrutura Lógica	Os documentos desenvolvidos possuem uma organização padronizada, com linguagem oficial.
Os conceitos-chave e a estrutura lógica do texto.	Diagnóstico precoce, atendimento especializado, fluxo institucional, barreiras de acesso.
Análise	Os documentos foram reunidos de acordo com a sua relevância para o objetivo da pesquisa.

Fonte: A autora, 2025.

Os documentos foram examinados acerca dos objetivos do estudo, buscando verificar como políticas públicas, fluxos institucionais e o acesso das famílias à rede de atendimento se articulam. Nesse sentido, as leituras sucessivas dos documentos permitiram refinar as categorias de análise e aprofundar a compreensão da intersectorialidade no contexto de Maricá. O levantamento documental preliminar concentrou-se no portal oficial da Prefeitura Municipal de Maricá, por se tratar da principal fonte institucional de informações públicas sobre a organização das políticas municipais. Adicionalmente, foram utilizados documentos de domínio público distribuídos pela Gerência de Orientação Educacional no ano de 2024.

O procedimento foi estruturado em etapas sequenciais, descritas abaixo no item 3.3.1 e no apêndice, com o objetivo de assegurar a reprodutibilidade da busca por outros pesquisadores ou avaliadores. Por fim, os achados documentais foram sistematizados e analisados conforme os critérios estabelecidos na Tabela 2.

3.3.1. BUSCA NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Etapa 1 – Definição dos critérios de seleção das informações

Foram consideradas, para fins de análise documental, exclusivamente as informações que atendessem aos seguintes critérios:

- a) fossem de acesso público e oficialmente divulgadas pela administração municipal;
- b) estivessem relacionadas ao atendimento de crianças com TEA ou às políticas de saúde, educação e assistência social com interface com a infância;
- c) apresentassem descrição institucional de serviços, ações, público atendido ou formas de acesso.

Etapa 2 – Identificação das secretarias e serviços pertinentes

A partir dos critérios estabelecidos, foram acessadas as páginas das Secretarias Municipais com atuação direta ou indireta no atendimento às crianças com TEA. Nessas páginas, foram consultadas subseções relacionadas a serviços e equipamentos públicos, conforme ilustrado nas Figuras 2 a 6, que exemplificam informações disponibilizadas nos canais oficiais do município.

Etapa 3 – Registro e organização das informações

As informações identificadas foram registradas de forma sistemática, considerando o serviço ou equipamento, a secretaria responsável, o público atendido, os objetivos institucionais e as formas de acesso divulgadas. Esse registro teve caráter organizacional e descritivo, para que mais adiante ocorra, a interpretação dos dados.

A sequência metodológica das etapas de procedimentos desenvolvidas na análise documental permitiu delimitar o conjunto de documentos da pesquisa e organizar o material de forma transparente e reproduzível, subsidiando a etapa subsequente de análise de dados.

3.3.2. CARACTERIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS

A pesquisa é composta por documentos normativos, orientadores e institucionais relacionados às políticas públicas de saúde e educação, com ênfase na articulação intersetorial entre esses setores no âmbito do PSE, na vigilância do

desenvolvimento infantil e no atendimento a crianças com TEA na Educação Infantil. A segunda etapa de seleção dos documentos considerou materiais de abrangência nacional e municipal, de modo a possibilitar a análise das diretrizes gerais estabelecidas pelas políticas públicas federais e sua materialização no contexto local do município de Maricá, no estado do Rio de Janeiro.

Integram o conjunto documental os documentos de âmbito nacional, tais como legislações federais, diretrizes do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, materiais orientadores do Programa Saúde na Escola e a Linha de Cuidado para a Atenção às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Esses documentos estabelecem princípios, responsabilidades institucionais e orientações gerais relacionadas à identificação precoce, ao cuidado integral e à garantia de direitos das crianças com TEA na primeira infância.

Compõem também o conjunto de documentos analisados, aqueles de âmbito municipal incluindo planos, normativas, programações e materiais institucionais produzidos pela gestão pública de Maricá, além de dados educacionais referentes à rede municipal de ensino. Esses documentos possibilitam compreender a organização local dos serviços, os dispositivos existentes para o atendimento às crianças com TEA e o contexto de expansão da Educação Infantil e da Educação Especial no município.

Para fins de organização, sistematização e análise, cada documento foi identificado por um código alfanumérico (D1, D2, D3, D4 e D5), adotado com o objetivo de facilitar o manuseio do material, evitar a repetição de títulos extensos ao longo do texto e assegurar maior clareza e padronização na apresentação dos resultados. A caracterização dos documentos considerou aspectos como ano de publicação, órgão emissor, esfera administrativa (nacional ou municipal), tipo documental e a relação com os objetivos da pesquisa, conforme apresentado na tabela 3.

A seleção e caracterização documental seguiram um percurso sistemático, fundamentado nas orientações de Cellard (2008), constituindo uma etapa fundamental do percurso metodológico da pesquisa, para delimitar de forma clara o material analisado e garantir integridade e confiabilidade ao processo investigativo. A partir desta fase, procedeu-se à análise temática, orientada pelas categorias e subcategorias previamente definidas e apresentadas na tabela 3 (três), com o

objetivo de identificar convergências, lacunas e desafios relacionados à articulação intersetorial entre saúde e educação e às implicações dessas diretrizes para a identificação precoce e o atendimento de crianças com TEA na Educação Infantil no município de Maricá.

3.3. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos dados foi realizada a partir de uma abordagem qualitativa de natureza temática, aplicada ao conjunto de documentos selecionados. O processo de análise desenvolveu-se de forma sistemática e progressiva. Inicialmente, foi realizada uma leitura flutuante, com o objetivo de proporcionar uma visão geral do material e possibilitar a familiarização com os temas recorrentes relacionados ao atendimento de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), à Educação Infantil, Programa Saúde na escola e à articulação intersetorial entre saúde e educação. Essa etapa permitiu identificar elementos centrais para a organização do material e orientar as etapas subsequentes da análise.

Na sequência, realizaram-se leituras sucessivas, mais aprofundadas, nas quais os documentos foram examinados à luz dos objetivos da pesquisa. Nessa fase, trechos considerados relevantes foram destacados, respeitando-se o contexto de produção, a autoria institucional e a finalidade de cada documento. Esse procedimento possibilitou a sistematização das informações presentes nas fontes analisadas e favorecendo a compreensão das diretrizes, responsabilidades e fluxos relacionados ao cuidado e à atenção às crianças com TEA.

A organização e a interpretação dos dados foram realizadas por categorias previamente definidas, que funcionaram como eixos estruturantes do processo interpretativo. Essas categorias permitiram agrupar os conteúdos documentais segundo temas comuns, favorecendo a identificação de alinhamentos, lacunas e complementaridades entre documentos de abrangência nacional e municipal. As subcategorias foram utilizadas como dimensões analíticas internas, contribuindo para o aprofundamento da análise.

Os documentos foram analisados considerando suas diferentes esferas administrativas e contextos de produção. Essa perspectiva possibilitou compreender como as diretrizes gerais das políticas públicas nacionais se apresentam e se

materializam ou não no contexto local do município de Maricá, evidenciando aproximações, distanciamentos e desafios na articulação intersetorial entre saúde e educação.

Os achados decorrentes dessa análise são apresentados nos resultados, organizados a partir das categorias analíticas definidas, com a incorporação de trechos selecionados dos documentos como evidências empíricas que sustentam as interpretações realizadas. Os resultados subsidiaram, ainda, a elaboração do produto educacional desta dissertação, produzido como resultado decorrente dos dados analisados, voltado à organização e à comunicação do percurso de atendimento às crianças com TEA na rede municipal de Maricá.

3.3.1. CATEGORIAS DE ANÁLISE

As categorias de análise foram definidas a partir dos objetivos geral e específicos da pesquisa, do referencial teórico sobre Educação Infantil, TEA, diagnóstico e intervenção precoce, intersetorialidade e políticas públicas, bem como das diretrizes normativas que orientam o PSE e a organização da rede de atenção às crianças com TEA. Optou-se pela construção de categorias, capazes de apreender os sentidos presentes nos documentos e de favorecer uma análise interpretativa, contextualizada e coerente com o objeto investigado.

A primeira categoria: *Intersetorialidade entre saúde e educação no âmbito do PSE* refere-se às concepções e diretrizes que orientam a articulação entre os setores de saúde e educação nas políticas públicas voltadas à infância. Essa categoria abrange os documentos que tratam da organização dos papéis institucionais atribuídos a cada setor, das responsabilidades compartilhadas e das formas de articulação previstas para o desenvolvimento de ações conjuntas, bem como dos desafios e lacunas que dificultam a efetivação do trabalho intersetorial no cotidiano dos serviços.

A segunda categoria: *Vigilância do desenvolvimento e identificação precoce do Transtorno do Espectro Autista* contempla os enunciados normativos e orientadores relacionados ao acompanhamento do desenvolvimento infantil, à observação de sinais de risco e às estratégias de identificação precoce do TEA. Essa categoria inclui as diretrizes que abordam o papel da Educação Infantil e da

Atenção Primária à Saúde nesse processo, bem como as orientações referentes aos encaminhamentos previstos no âmbito das políticas públicas, sem se deter em procedimentos operacionais específicos.

Por fim, a terceira categoria: *Direitos, inclusão e políticas públicas para crianças com TEA* reúne os dispositivos legais e normativos que asseguram o direito à inclusão educacional, à atenção precoce e ao cuidado integral das crianças com TEA. Essa categoria compreende os princípios e diretrizes das políticas públicas voltadas à inclusão, os desafios relacionados à implementação dessas garantias no contexto municipal, considerando as especificidades da rede pública de Maricá.

Essa organização categórica orientou a leitura interpretativa de todos os documentos que estruturaram a apresentação dos resultados, permitindo a articulação entre os documentos analisados, o referencial teórico e os objetivos da pesquisa, sem fragmentar excessivamente a análise ou antecipar interpretações.

4. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

4.1. ANÁLISE DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO TEA EM MARICÁ

A análise documental seguiu um percurso sistemático, de natureza qualitativa e interpretativa, fundamentado nas contribuições de Cellard (2008) e Bardin (2011), de modo a assegurar rigor metodológico e alinhamento com os objetivos da pesquisa. Considerando que o material é composto por documentos normativos, orientadores e institucionais, a análise buscou compreender não apenas os conteúdos explicitamente apresentados, mas também os sentidos produzidos a partir de sua organização, articulação e eventuais lacunas.

Conforme descrito por Cellard (2008), os documentos foram examinados de forma contextualizada, considerando sua autoria institucional, o período de publicação, os objetivos declarados e o papel que ocupam na estruturação das políticas públicas de saúde e educação. Ao final da etapa de tratamento e interpretação dos resultados, os achados documentais foram articulados aos objetivos da pesquisa, evidenciando como as políticas públicas analisadas estruturam, ou como estão ausentes no percurso intersetorial de vigilância do desenvolvimento, identificação precoce e atendimento das crianças com TEA.

Visando sistematizar o processo de análise documental, foi elaborada uma matriz de categorização temática, que organiza as categorias, subcategorias,

núcleos de sentido e respectivas fontes dos dados. Essa matriz orientou a leitura analítica dos documentos selecionados e subsidiou a interpretação dos achados apresentados nos resultados. Abaixo temos a tabela 3 que sintetiza as categorias, subcategorias, núcleos de sentido e respectivas fontes, que estruturam o processo de análise documental desta pesquisa.

Quadro 3 – Matriz de categorização temática utilizada para análise dos dados coletados.

Categoria	Subcategoria	Núcleo de Sentido	Fontes dos Dados
1. Intersectorialidade entre saúde e educação	Papéis da saúde	Responsabilidade da Atenção Primária à Saúde na vigilância do desenvolvimento, orientação às famílias e encaminhamento para a rede de cuidados.	Linha de Cuidados para pessoas com TEA; Caderno do Gestor PSE 2022.
	Papéis da educação	Responsabilidade da Atenção Primária à Saúde na vigilância do desenvolvimento, orientação às famílias e encaminhamento para a rede de cuidados.	Caderno do Gestor PSE 2022; Plano Municipal de Educação (PME)/ Plano Municipal de Saúde.
	Atribuições compartilhadas	Ações conjuntas entre saúde e educação, especialmente no âmbito do PSE, voltadas à promoção do desenvolvimento infantil e à articulação intersectorial.	Linha de Cuidados para pessoas com TEA; Caderno do Gestor PSE 2022.
	Dispositivos Institucionais de Orientação e Organização Municipal	Instrumentos normativos e planos municipais que organizam, orientam e estruturam a circulação de informações e ações intersectoriais no território.	Plano Municipal de Educação (PME)/ Plano Municipal de Saúde.
2. Vigilância do desenvolvimento e identificação precoce do TEA	Papel da APS	Centralidade da APS como porta de entrada do SUS, responsável pelo acompanhamento do desenvolvimento infantil e pela identificação precoce de sinais de risco.	Linha de Cuidados para pessoas com TEA; Marco Legal da Primeira Infância - Lei nº 13.257/2016; Lei nº 14.880/2024 – Política Nacional de Atenção Precoce.
	Instrumentos de Triagem	Utilização de instrumentos padronizados para rastreio do desenvolvimento e identificação de sinais precoces de TEA na primeira infância.	Linha de Cuidados para pessoas com TEA; Marco Legal da Primeira Infância - Lei nº 13.257/2016; Lei nº 14.880/2024 – Política Nacional de Atenção Precoce.

	Papel da Educação Infantil	Contribuição da escola na vigilância do desenvolvimento por meio da observação sistemática, registro e comunicação com a família e a saúde.	Caderno do Gestor PSE 2022; Plano Municipal de Educação (PME)/ Plano Municipal de Saúde.
	Vigilância do Desenvolvimento	Monitoramento contínuo dos marcos do desenvolvimento infantil como estratégia de cuidado, prevenção e identificação de atrasos.	Linha de Cuidados para pessoas com TEA; Marco Legal da Primeira Infância - Lei nº 13.257/2016; Lei nº 14.880/2024 – Política Nacional de Atenção Precoce.
	Atenção Precoce	Prioridade de ações intersetoriais voltadas às crianças de 0 a 3 anos com sinais de alerta ou risco ao desenvolvimento.	Marco Legal da Primeira Infância - Lei nº 13.257/2016; Lei nº 14.880/2024 – Política Nacional de Atenção Precoce.
	Ausência de Fluxos Formais	Fragilidade na formalização e divulgação de fluxos municipais claros para suspeita, encaminhamento e acompanhamento do TEA.	Plano Municipal de Educação (PME)/ Plano Municipal de Saúde.
3. Direitos, Inclusão e Políticas para Crianças com TEA na Educação Infantil	Garantias Legais	Reconhecimento do TEA como condição assegurada por direitos à saúde, educação e inclusão social.	Lei nº 12.764/2012 Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) Marco Legal da Primeira Infância - Lei nº 13.257/2016; Lei nº 14.880/2024 – Política Nacional de Atenção Precoce.
	Inclusão e Atenção Precoce	Articulação entre políticas de inclusão educacional e estratégias de identificação e intervenção precoce.	Lei nº 12.764/2012 Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA); Marco Legal da Primeira Infância - Lei nº 13.257/2016; Lei nº 14.880/2024 – Política Nacional de Atenção Precoce.
	Formação e responsabilização dos Profissionais	Necessidade de qualificação contínua de profissionais da educação e da saúde para atuação inclusiva e intersetorial.	Caderno do Gestor PSE 2022; Lei nº 12.764/2012 Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA);
	Garantias Legais na Primeira Infância	Prioridade absoluta às crianças pequenas com TEA ou sinais de risco, conforme marcos legais da primeira infância.	Marco Legal da Primeira Infância - Lei nº 13.257/2016; Lei nº 14.880/2024 – Política Nacional de Atenção Precoce.

	Compromissos Locais	Diretrizes e metas municipais voltadas à inclusão, ao atendimento educacional especializado e à articulação intersetorial.	Plano Municipal de Educação (PME)/ Plano Municipal de Saúde.
	Lacunas/Desafios	Distanciamento entre a normatização legal e a operacionalização prática das políticas no território.	Plano Municipal de Educação (PME)/ Plano Municipal de Saúde.

Fonte: A autora, 2025.

A matriz de categorização apresentada orientou todo o processo de análise documental desenvolvido nesta pesquisa, que a partir das categorias e subcategorias definidas constituiu o eixo organizador para a seleção, codificação e interpretação dos trechos extraídos dos documentos analisados (D1 a D5).

4.2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS DOCUMENTOS

Essa pesquisa tem relevância para o município de Maricá, pois segundo dados do INEP de 2024, com o aumento da rede educacional e número de matrículas na rede

A análise documental realizada nesta pesquisa teve como base um corpus composto por documentos normativos, orientadores e institucionais, de abrangência nacional e municipal, relacionados às políticas públicas de saúde e educação voltadas à primeira infância e ao atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os documentos foram selecionados considerando sua relevância para a organização do cuidado, da identificação precoce e da articulação intersetorial no contexto do município de Maricá.

O corpus analisado foi sistematizado em cinco documentos, identificados como D1, D2, D3, D4 e D5, conforme descrito na tabela 4. E para cada categoria foi selecionado um trecho do material, realizada a interpretação inicial, identificando as implicações para o município de Maricá, conforme a tabela abaixo na qual pode-se identificar as orientações para atuação colaborativa entre saúde e educação em nível nacional, até as implicações para o município de Maricá.

Quadro 4 - Caracterização do conjunto de documentos

Código	Documento	Ano	Órgão	Tipo	Relação com o Tema
D1	Linha de Cuidado para Pessoas com TEA – MS	2021	Nacional – MS	Diretriz / Linha de Cuidado	Vigilância, fluxo, intersectorialidade
D2	Caderno do Gestor – Programa Saúde na Escola	2018	Nacional – MS/MEC	Diretriz	Intersectorialidade, responsabilidades saúde–educação
D3	Lei nº 12.764 – Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA.	2012	Nacional	Lei Federal	Direitos, inclusão, atenção precoce
D4	Marco Legal da Primeira Infância - Lei nº 13.257/2016; Lei nº 14.880/2024 – Política Nacional de Atenção Precoce.	2016 - 2024	Nacional	Lei Federal	Vigilância do desenvolvimento, triagem
D5	Plano Municipal de Educação / Plano Municipal de Saúde 2022-2025.	2014 - 2024	Municipal	Plano	Diretrizes locais sobre inclusão, TEA, EI

Fonte: A autora, 2025.

Este tópico apresenta os resultados da análise documental realizada a partir dos materiais selecionados, composto por instrumentos normativos, orientadores e informações públicas disponibilizadas por órgãos federais e pela Prefeitura Municipal de Maricá. Os resultados são apresentados e discutidos, considerando as categorias definidas, com o objetivo de compreender como as políticas públicas e os documentos institucionais organizam o atendimento às crianças com TEA, especialmente no que se refere à articulação entre saúde e educação, à vigilância do desenvolvimento infantil, ao percurso de atendimento e à educação inclusiva no contexto municipal.

A caracterização do conjunto de documentos analisados evidencia a articulação entre as diretrizes nacionais e as normativas municipais, permitindo compreender como as responsabilidades legais e institucionais se distribuem entre os diferentes níveis de gestão. O que permite avaliar a organização do município de Maricá acerca dos recursos que atravessam o percurso de atendimento às crianças da Educação Infantil. Os resultados estão apresentados na forma de tabela que destaca por categorias os trechos selecionados dos documentos, a subcategoria de

organização destes, a interpretação inicial sobre a informação documental e suas implicações para o município.

Quadro 5: Matriz de Análise Temática da categoria 1

5A. Categoria 1 – Intersectorialidade Saúde – Educação / PSE

Documento	Trecho Selecionado	Subcategoria
D2	“O PSE atua em parceria com escolas e Unidades Básicas de Saúde (UBS), fortalecendo o vínculo entre estudantes, familiares, comunidade, equipes de saúde e equipes de educação, com vistas à promoção da saúde, prevenção de agravos e acompanhamento das condições de saúde dos educandos.”	Papéis da Saúde
D2	“O ambiente escolar é um espaço privilegiado para a promoção da saúde, para a identificação de necessidades dos estudantes e para o desenvolvimento de ações que favoreçam o cuidado integral, em articulação com a Atenção Primária à Saúde.”	Papéis da Educação
D2/D1	D2 – “A construção de responsabilidade compartilhada entre as equipes das escolas e da saúde é considerada uma estratégia privilegiada para a promoção da saúde e da qualidade de vida dos estudantes, sendo essencial para a continuidade do cuidado.” D1 – “A construção de responsabilidade compartilhada entre as equipes das escolas e da saúde é considerada uma estratégia privilegiada para a promoção da saúde e da qualidade de vida dos estudantes, sendo essencial para a continuidade do cuidado.”	Atribuições Compartilhadas
D5 (Maricá)	Os documentos estabelecem diretrizes para a articulação entre educação, saúde e assistência social, com destaque para o acompanhamento do desenvolvimento infantil, a garantia da educação inclusiva, o monitoramento das políticas públicas e a organização das ações no território, prevendo mecanismos de planejamento, avaliação e cooperação intersectorial.	Dispositivos institucionais de orientação e organização municipal

Fonte: A autora, 2025.

5B. Análise da Categoria 1 – Intersectorialidade Saúde – Educação / PSE

Documento	Interpretação Inicial	Implicações para o Município
D2	O documento atribui à Atenção Primária à Saúde (APS) um papel estruturante no acompanhamento das crianças no contexto escolar, destacando a UBS como espaço de referência para ações de promoção, prevenção e acompanhamento do desenvolvimento infantil. A saúde não aparece como instância contínua de cuidado e corresponsabilidade pelo desenvolvimento integral dos estudantes.	Para o município de Maricá, esse papel exige que as UBS estejam preparadas para acolher demandas oriundas da Educação Infantil, especialmente relacionadas à vigilância do desenvolvimento e aos sinais de risco para o TEA.
D2	O PSE reconhece a escola como espaço estratégico de observação cotidiana das crianças, conferindo à Educação Infantil um papel ativo na identificação de necessidades	Destaca a responsabilidade dos profissionais da Educação Infantil na observação sistemática do desenvolvimento das crianças e na

Documento	Interpretação Inicial	Implicações para o Município
	relacionadas ao desenvolvimento e à saúde. A escola é compreendida como parceira no cuidado e agente fundamental na percepção de sinais que demandam atenção intersetorial.	comunicação qualificada com as famílias e com a rede de saúde. Demandando formação continuada para os profissionais da educação e saúde.
D2/D1	A análise conjunta dos documentos evidencia que a intersectorialidade é tratada como princípio organizador do cuidado. Saúde e educação compartilham responsabilidades na identificação, no acompanhamento e na continuidade do cuidado às crianças com TEA, sendo a APS o eixo articulador e a escola o espaço privilegiado de observação e vínculo cotidiano.	Faz-se necessário a organização de fluxos intersectoriais que conectem escola, UBS e serviços especializados, superando a lógica de encaminhamentos isolados. Identificando os papéis de cada setor, favorecendo a continuidade do cuidado e reduzindo barreiras de acesso enfrentadas pelas famílias.
D5 (Maricá)	Os planos municipais analisados atuam como dispositivos estruturantes da política pública, organizando responsabilidades institucionais e orientando a articulação entre setores. No entanto, essas orientações permanecem majoritariamente no nível técnico-administrativo, sem detalhamento operacional acessível às famílias.	Necessidade de instrumentos para comunicar, em linguagem acessível para a população, os caminhos das instituições de forma organizada e compreensível.

Fonte: A autora, 2025.

Os dados acima mostram que a intersectorialidade entre saúde e educação é destacada como um componente central do PSE e considerada uma condição indispensável para o cuidado integral das crianças. Entretanto, a análise dos documentos revela que essa articulação no âmbito municipal ainda necessita de estruturação de estratégias claras para que se concretize no cotidiano.

4.3 INTERSETORIALIDADE ENTRE SAÚDE E EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AO TEA: ANÁLISE DOCUMENTAL

A análise dos documentos evidencia que a intersectorialidade entre saúde e educação é amplamente reconhecida como princípio estruturante das políticas públicas voltadas à infância e ao atendimento de crianças com TEA. Nos documentos nacionais (D1, D2 e D4), a articulação entre os setores aparece como condição necessária para garantir o cuidado integral, a vigilância do desenvolvimento e o acesso aos serviços especializados. Os papéis atribuídos à saúde concentram-se na vigilância do desenvolvimento, na avaliação clínica, na coordenação do cuidado pela Atenção Primária à Saúde (APS) e na organização dos fluxos assistenciais. Já à educação são atribuídas funções relacionadas à

observação cotidiana do desenvolvimento infantil, à identificação de sinais de alerta no contexto escolar e ao diálogo com as famílias.

Entretanto, a análise do documento municipal (D5) revela que, embora haja reconhecimento formal da importância da intersetorialidade, os dispositivos institucionais de orientação e organização municipal ainda se apresentam de forma fragmentada. Observa-se a ausência de protocolos integrados e de fluxos claramente definidos que orientem, de maneira sistemática, a comunicação entre escola, serviços de saúde e famílias. Essa lacuna evidencia um descompasso entre as diretrizes normativas nacionais e sua materialização no território local. Tal constatação reforça a necessidade de instrumentos que organizem essas orientações em percursos acessíveis e compreensíveis para toda a população.

Quadro 6 – Matriz de análise temática da categoria 2

6A. Categoria 2 - Vigilância do desenvolvimento e identificação precoce no TEA

Documento	Trecho Selecionado	Subcategoria
D1	“A Atenção Primária à Saúde é responsável pela vigilância do desenvolvimento infantil, identificação precoce de sinais de risco e encaminhamento oportuno para avaliação especializada.”	Papel da APS
D1	“A identificação de sinais de risco deve ocorrer a partir da observação dos marcos do desenvolvimento e da utilização de instrumentos de triagem validados.”	Instrumentos de Triagem
D1	“Identificados sinais de risco, a criança deve ser encaminhada para avaliação especializada, garantindo continuidade do cuidado em rede.”	Fluxo de Suspeita
D2	“A escola, em articulação com a saúde, participa da observação do desenvolvimento infantil e da identificação de sinais que demandem avaliação em saúde.”	Papel da Educação Infantil
D4	“As políticas públicas para a primeira infância devem ser executadas de forma articulada, com vigilância do desenvolvimento e prioridade à identificação precoce de riscos.”	Vigilância do desenvolvimento
D4	“É instituída a Política Nacional de Atendimento Educacional Especializado a crianças de zero a três anos, priorizando a identificação precoce de sinais de risco ao desenvolvimento.”	Atenção Precoce
D5	Não há descrição explícita de fluxos formais de vigilância do desenvolvimento ou de identificação precoce do TEA nos documentos analisados.	Ausência de Fluxos Formais

Fonte: A autora, 2025.

6B. Análise da Categoria 2 - Vigilância do desenvolvimento e identificação precoce no TEA

Documento	Interpretação Inicial	Comparação Nacional x Municipal
D1	O documento atribui à APS papel central na vigilância do desenvolvimento e na identificação precoce de sinais associados ao TEA, destacando sua função como porta de entrada do cuidado.	Em nível nacional, há definição clara do papel da APS. Em nível municipal, não há detalhamento público de protocolos específicos voltados ao TEA.
D1	Há definição de quem deve identificar os sinais de risco com base nos marcos do desenvolvimento e instrumentos de triagem.	Em nível nacional, orientação para identificação precoce e observação clínica contínua. Em nível municipal ausência de orientação.
D1	O documento orienta claramente sobre o passo seguinte a observação de sinais de risco para TEA.	Nacionalmente há recomendação para encaminhamento quando observados sinais de risco. No município, não há menção sobre recomendações.
D2	O PSE reconhece a escola como espaço privilegiado de observação cotidiana do desenvolvimento, reforçando sua função intersetorial.	Nacionalmente, destaca o papel de observação do espaço escolar. No âmbito municipal ausência de definição de papéis na observação do desenvolvimento.
D4	Estabelece a vigilância do desenvolvimento como dever do Estado, com abordagem intersetorial e foco preventivo.	Em nível nacional, orienta todos os entes federativos quanto à vigilância do desenvolvimento. Maricá, não apresenta informações.
D4	A lei amplia a responsabilidade do poder público, integrando educação e saúde na identificação e intervenção precoce.	A diretriz nacional é explícita na responsabilidade integrada. Maricá ainda não apresenta regulamentação local sobre o trabalho integrado de educação e saúde.
D5	A ausência de fluxos formalizados indicando lacuna entre a normatização nacional e a organização municipal.	Maricá não apresenta organização clara dos caminhos institucionais para a identificação precoce do TEA.

Fonte: A autora, 2025.

A análise da Categoria evidencia que a vigilância do desenvolvimento infantil e a identificação precoce do TEA constituem eixos centrais das políticas públicas nacionais, sustentadas por diretrizes que atribuem papéis complementares à Atenção Primária à Saúde e à Educação Infantil. Nos documentos nacionais, observa-se a definição e orientação explícita de compartilhamento de responsabilidades no processo de observação cotidiana do desenvolvimento infantil, para que na possibilidade de risco para TEA, sejam feitos os encaminhamentos para identificação e intervenção precoce.

No contexto municipal, entretanto, a análise documental não identificou a publicização de fluxos formais ou protocolos integrados que orientem ou descrevam,

de maneira sistemática, a articulação intersetorial. Essa lacuna é um entrave que dificulta a comunicação entre escola, serviços de saúde e famílias e evidencia um distanciamento entre as diretrizes nacionais e sua materialização no território local. Esse descompasso indica a não eficiência das ações intersetoriais no município e lacuna na organização da comunicação institucional dos percursos de atendimento, o que pode dificultar o acesso oportuno das famílias aos serviços disponíveis. Tal constatação reforça a importância de instrumentos que sistematizem e tornem acessíveis as informações sobre o percurso de identificação e atendimento do TEA.

A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Pessoa com Deficiência e Inclusão (SPCDI), oferece uma rede de serviços estruturada e gratuita que viabiliza o atendimento terapêutico para pessoas com TEA no município. Os dados levantados sobre a rede de atendimento foram disponibilizados no produto educacional. Entre os principais equipamentos e serviços disponíveis, podemos citar a Casa do Autista; o SAREM (Serviço de Atendimento de Reabilitação Especial de Maricá) I e II; o CAIF (Centro de Atenção Integral à Família de PCDs); o Centro de Reabilitação; a Equoterapia e Cinoterapia. Cada um desses serviços cumpre funções específicas dentro do percurso intersetorial - seja no diagnóstico, na intervenção terapêutica, no acompanhamento longitudinal ou no suporte à inclusão escolar.

Figura 1: Setores específicos ao tratamento do TEA

Casa do Autista  Público: Pessoas com TEA a partir de 12 anos  Objetivo: Habilitação e reabilitação em atividade de vida diária de jovens, adolescentes e adultos.  Equipe: Fonoaudiólogos, Psicólogos, Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta, Psicomotricista, Musicoterapeuta, Nutricionista, Psicopedagogo, Assistente Social.
SAREM  Público: Atraso no desenvolvimento Neuropsicomotor; Deficiência Auditiva e Surdez; Deficiência Intelectual sem etiologia definida; Deficiência motora; Deficiência Visual / Baixa Visão; Distúrbios de deglutição; Encefalopatia crônica da infância; Epilepsia; erros Inatos do Metabolismo; Fenda Palatina / Lábio leporino; Hidrocefalia; Má formação congênita; Microcefalia; Multideficiências; Sequelas de traumatismo cranioencefálico; Sequelas de tumor cerebral; Síndrome Alcoólica Fetal; Síndromes genéticas em geral; Transtorno do Espectro Autista; TDAH com prejuízos na aprendizagem - Do nascimento até os 12 anos.  Objetivo: Atua na prevenção, diagnóstico e no tratamento não apenas da doença, mas também seus efeitos e consequências na vida do indivíduo.  Equipe: Informação não encontrada

Fonte: Documentos de divulgação da PMM, 2024

Figura 2: Equipamentos e setores públicos e gratuitos para suporte terapêutico em Maricá

CAIF 1 e 2

 **Público:** pessoas com deficiência múltipla e intelectual moderada ou grave, familiares de pessoas com deficiência.

 **Objetivo:** Inclusão, reabilitação e convivência social

 **Oficinas:** Capoeira; Percursão e Conceito musical; Expressão corporal; Ginástica; Arteterapia; Pintura; Teatro; Cordas e Musicalização; Instrumentos Percurssivos e Recicláveis; Dança

Centro de Reabilitação

 **Público:** Deficiência Intelectual sem etiologia definida; Deficiência motora; Distúrbios da fala; Distúrbios de deglutição; Encefalopatia crônica da infância; Epilepsia; erros inatos do metabolismo; Fenda palatina / Lábio leporino; Hidrocefalia; Má formação congênita; Microcefalia; Multideficiências; Sequelas de Traumatismo cranioencefálico, Sequelas de tumor cerebral; Síndrome Alcoólica Fetal; Síndrome Genéticas em geral.

 **Objetivo:** Proporcionar melhora da funcionalidade e qualidade de vida.

 **Equipe:** Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Nutricionista, Fonoaudiólogo, Assistente Social, Fisioterapeuta, Técnico de Enfermagem, Educador Físico .

Fonte: Documentos de divulgação da PMM, 2024

Figura 3: Detalhamento do serviço público de Equoterapia de Maricá disponibilizado na formação dos profissionais da Orientação Educacional

Equoterapia

 **Público:** Pessoas com deficiência com idades entre 03 a 21 anos

 **Objetivo:** Desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência.

 **Equipe:** Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta, Psicólogo, Assistente Social, Auxiliar guia de equitação

A consulta a essas informações permitiu compreender como a política municipal organiza seus serviços e como a rede de suporte às crianças com deficiência se estrutura, incluindo o suporte a aquelas com TEA.

4.4 DIREITOS, INCLUSÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS COM TEA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Os documentos analisados reafirmam o direito das crianças com TEA à educação inclusiva, ao atendimento em saúde e ao acesso a políticas públicas que garantam seu desenvolvimento integral. As legislações nacionais estabelecem garantias legais claras quanto à prioridade de atendimento na primeira infância, à oferta de apoios especializados e à articulação entre políticas educacionais, de saúde e de assistência social.

No âmbito municipal, observa-se a presença dessas garantias no PME, todavia, a análise evidencia que a efetivação desses direitos de forma plena por todos os munícipes carece de sistematização dos serviços, formas de acesso e comunicação eficaz às famílias. As lacunas identificadas não se referem à inexistência de políticas, mas ao acesso às informações, cenário que contribui para percursos fragmentados, longos períodos de busca por atendimentos, sobrecarga das famílias e uso pouco eficiente dos recursos disponíveis.

Quadro 7 – Matriz de análise temática da categoria 3

7A. Categoria 3 - Direitos, Inclusão e Políticas Públicas

Documento	Trecho Selecionado	Subcategoria
D3	“A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.”	Garantias Legais
D3/D1	“A atenção à pessoa com TEA deve ocorrer de forma integral, contínua e articulada, considerando suas necessidades específicas.”	Inclusão e Atenção Precoce
D2	“Cabe às equipes de educação e saúde identificar necessidades dos estudantes e articular ações conjuntas de promoção e cuidado.”	Formação e Responsabilidade dos Profissionais
D4	“As políticas públicas para a primeira infância devem ser	Garantias Legais na

	formuladas e executadas de forma intersetorial, com prioridade ao desenvolvimento integral.”	Primeira Infância
D5	“As diretrizes municipais prevêem ações inclusivas, porém sem detalhamento operacional dos fluxos intersetoriais.”	Compromissos Legais
D5+ Análise Integrada	Ausência de protocolos públicos e orientações acessíveis às famílias nos canais oficiais.	Lacunas/Desafios

Fonte: A autora, 2025.

7B. Análise da Categoria 3 - Direitos, Inclusão e Políticas Públicas

Documento	Interpretação Inicial	Implicações para a Educação Infantil em Maricá
D3	A legislação reconhece o TEA como deficiência, assegurando direitos no acesso à saúde, educação e proteção social desde a primeira infância.	Garantia de matrícula em escola regular, apoio pedagógico. Acesso a serviços de saúde.
D3/D1	Os documentos convergem ao afirmar a necessidade de atenção integral e precoce, com articulação entre saúde e educação.	Reforça a importância do trabalho colaborativo entre Educação e saúde no acompanhamento desde os primeiros sinais de risco.
D2	O PSE atribui responsabilidade compartilhada à escola e à saúde na identificação de necessidades e no acompanhamento das crianças.	Demanda formação continuada dos profissionais da Educação Infantil e da APS para observação do desenvolvimento.
D4	As leis reforçam a centralidade da intersetorialidade e da atenção precoce como dever do Estado, com prioridade absoluta à criança pequena.	Necessidade de ações de atenção, para crianças com sinais de risco para TEA.
D5	Os planos municipais reconhecem a inclusão e o cuidado à infância, mas não explicitam como os fluxos ocorrem na prática.	Organização prática dos fluxos de acesso aos serviços de cuidados à primeira infância.
D5+ Análise Integrada	A falta de informação clara compromete o acesso aos direitos garantidos legalmente.	Estruturação das informações sobre os serviços públicos a fim de garantir o uso adequado.

Fonte: A autora, 2025.

Os dados da matriz acima indicam que o município de Maricá dispõe de garantias legais para a inclusão educacional, a atenção precoce e o cuidado integral das crianças com TEA. Contudo, a análise dos documentos também evidencia o desafio de concretizar a articulação entre os setores e qualificar continuamente equipes para o atendimento às crianças da primeira infância.

5. RESULTADOS

5.1. SÍNTESE DOS ACHADOS DA REVISÃO DE LITERATURA

A revisão de literatura indica que os estudos nacionais destacam de forma recorrente a relevância do diagnóstico e da intervenção precoce no TEA, preferencialmente antes dos três anos de idade. Os achados evidenciam que a identificação precoce de sinais de alerta, associada à implementação oportuna de intervenções terapêuticas e pedagógicas personalizadas, potencializa o desenvolvimento neuropsicomotor, comunicativo e social das crianças, além de favorecer processos mais efetivos de inclusão escolar.

Os estudos analisados destacam a complexidade e a heterogeneidade⁵ do espectro autista, reforçando a necessidade de abordagens individualizadas e multiprofissionais, que envolvam de forma articulada os setores da saúde e da educação. Nesse contexto, a família e a escola são reconhecidas como espaços privilegiados de observação do desenvolvimento infantil, desempenhando papel central na identificação de alterações dos marcos do desenvolvimento e de sinais de alerta.

A literatura também aponta a Atenção Primária à Saúde como eixo estratégico para a vigilância do desenvolvimento e o encaminhamento adequado das crianças com sinais de atraso, bem como a Educação Infantil como espaço fundamental para a observação comparativa do desenvolvimento em contextos coletivos. Instrumentos de triagem validados, fluxos de encaminhamento bem definidos e comunicação intersetorial estruturada são destacados como essenciais para o cuidado integral. Esses achados reforçam a necessidade de estratégias que promovam a articulação entre políticas públicas, serviços e atores envolvidos no cuidado à criança com TEA.

Por fim, os estudos evidenciam a importância de pesquisas capazes de analisar como as diretrizes nacionais se materializam nos territórios e de identificar

⁵ Heterogeneidade, no âmbito do TEA, diz respeito à multiplicidade de perfis presentes no espectro, de modo que cada criança pode apresentar características, formas de comunicação, ritmos de desenvolvimento e necessidades de apoio distintas, o que requer respostas educacionais e de cuidado sensíveis às singularidades do sujeito (LACERDA, 2017; 2021).

lacunas entre o que está previsto normativamente e o que é efetivamente vivenciado pelas famílias. Esses achados fundamentaram a definição das categorias e subcategorias analíticas desta pesquisa, orientando a análise documental apresentada neste capítulo e a construção do produto educacional proposto.

5.2. SÍNTESE DOS ACHADOS DA REVISÃO DOCUMENTAL

A análise documental permitiu identificar que o município de Maricá dispõe de um arcabouço normativo alinhado às diretrizes nacionais no que se refere ao atendimento de crianças com TEA. Contudo, persistem desafios relacionados à integração entre os setores, à formalização dos fluxos de encaminhamento e à comunicação das informações às famílias e aos profissionais.

As categorias analisadas convergem para a constatação de que a intersectorialidade, embora prevista em documentos, ainda depende de dispositivos operacionais com a descrição sistemática de atuação dos setores da educação e saúde. Essa lacuna reforça a pertinência de um guia que contenha o caminho de acesso aos serviços disponíveis no município.

Quadro 8: Serviços Públicos Municipais

Secretaria	Serviço / Equipamento	Descrição Geral
Assistência Social	Casa do Autista	Atendimento especializado para pessoas com TEA
Assistência Social	Centro de Reabilitação	Serviços de reabilitação multiprofissional
Assistência Social	SAREM	Atendimento e reabilitação especial
Assistência Social	Equoterapia	Terapia assistida por cavalos
Assistência Social	CAIF	Centro de políticas inclusivas
Educação	Inclusão Educacional	Salas de recursos, mediadores, APD, Libras e Braille

Pessoa com Deficiência	Serviços diversos	Passe especial, aparelhos auditivos e transporte conveniado
------------------------	-------------------	---

Fonte: A autora, 2025.

Quadro 9 – Síntese dos achados documentais da pesquisa

Categorias	Principais achados documentais	Lacunas Identificadas	Implicações para o PSE e a Educação Infantil
Intersetorialidade Saúde– Educação	Os documentos nacionais reconhecem a intersetorialidade como eixo estruturante do cuidado, com atribuições definidas para saúde e educação, especialmente no âmbito do PSE.	Ausência de instrumentos que comuniquem, de forma acessível, os fluxos intersetoriais às famílias.	Necessidade de instrumentos orientadores na articulação prevista em práticas compreensíveis.
Vigilância do Desenvolvimento e Identificação Precoce	Embasamento legal para vigilância do desenvolvimento uso de instrumentos de triagem e identificação precoce desde a primeira infância.	Fragilidade na formalização de fluxos locais e na explicitação do papel da escola como espaço de observação e alerta.	Organização dos papéis e ações de educação e saúde compartilhadas na observação do desenvolvimento infantil e sinais de risco para TEA.
Direitos, Inclusão e Políticas para Crianças com TEA na Educação Infantil	Fortalecer o papel da Educação Infantil no PSE de forma estratégica de vigilância compartilhada com a APS.	Ausência de sistematização das informações de acesso e funcionamento dos serviços públicos existentes.	Garantia do direito à inclusão, atendimento educacional especializado desde a Educação Infantil.

Fonte: A autora, 2025.

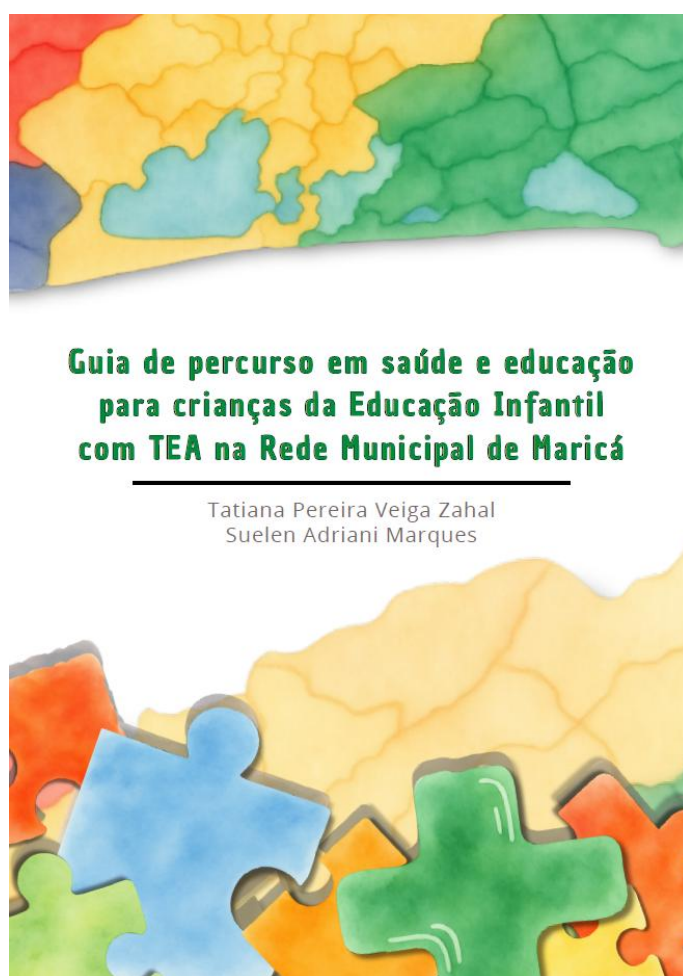
A análise dos documentos evidencia que, embora existam marcos legais, diretrizes técnicas e orientações acerca do atendimento da educação e saúde de maneira compartilhada no aspecto da vigilância do desenvolvimento, da identificação precoce e da inclusão de crianças com TEA, ainda existem fragilidades. Informações relevantes sobre serviços existentes, acesso e atendimento, encontram-se dispersas em diferentes páginas institucionais, o que caracteriza um ponto de atenção para a necessidade de organizar tais informações.

6. PRODUTO EDUCACIONAL

6.1 GUIA DE PERCURSO EM SAÚDE E EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM TEA NA REDE MUNICIPAL DE MARICÁ

O produto educacional desenvolvido neste mestrado profissional consiste em um Guia Digital em formato PDF, intitulado “*Guia de percurso em saúde e educação para crianças da Educação Infantil com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede municipal de Maricá*”. O guia visa organizar, sistematizar e tornar acessíveis as informações referentes ao percurso institucional de identificação, encaminhamento e atendimento de crianças com TEA no contexto da rede pública municipal de Maricá.

Figura 4: Capa do Guia digital



Fonte: A autora, 2025.

A elaboração do guia decorreu diretamente dos achados da análise documental apresentada, a qual evidenciou que, embora existam diretrizes nacionais consolidadas voltadas à intersetorialidade entre saúde e educação, à vigilância do desenvolvimento infantil e à atenção precoce, tais orientações nem sempre se materializam em fluxos institucionais claramente organizados e

comunicados no âmbito municipal. Observou-se a existência de uma rede de serviços relevante no atendimento a pessoas com autismo, porém marcada pela fragmentação das informações, pela ausência de dispositivos formalizados de orientação às famílias e pela pouca publicização dos caminhos institucionais existentes.

Nesse sentido, o guia foi concebido como um instrumento de mediação entre as normativas institucionais e o cotidiano das famílias e dos profissionais da rede, não com a finalidade de criar novos fluxos ou substituir a atuação técnica dos serviços, mas de traduzir, em linguagem clara e acessível, o percurso de acesso aos recursos disponíveis. No que se refere ao público-alvo, o guia destina-se prioritariamente a pais e responsáveis por crianças da Educação Infantil com sinais de risco ou diagnóstico de TEA, bem como a profissional da Educação Infantil e da Atenção Primária à Saúde que atuam diretamente na vigilância do desenvolvimento infantil e no acompanhamento.

O guia tem como propósito orientar, de maneira objetiva e acolhedora, sobre os direitos das crianças com TEA; como proceder ao suspeitar ou observar os sinais de alerta no desenvolvimento infantil; quais os papéis atribuídos à família, à escola e aos serviços de saúde; bem como o caminho disponível no município de Maricá para a busca de apoio, avaliação e acompanhamento. Ao explicitar etapas e responsabilidades, o produto busca contribuir para a redução de incertezas, o fortalecimento da articulação intersetorial e o acesso mais oportuno aos serviços disponíveis na rede pública. Ele está organizado em 7 capítulos (Quadro 2), distribuídos nos seguintes tópicos: 1. O que é o transtorno de espectro autista (TEA) e por que falar de diagnóstico precoce; 2. Direitos da criança com TEA e educação inclusiva; 3. Vigilância do desenvolvimento: quando acender o alerta; 4. Percurso institucional em Maricá: papéis e responsabilidades no atendimento ao TEA; 5. Articulação entre saúde e educação: cuidar juntos; 6. Orientações práticas finais; 7. Referências bibliográficas.

Quadro 10: Estrutura do Produto Educacional: Sumário

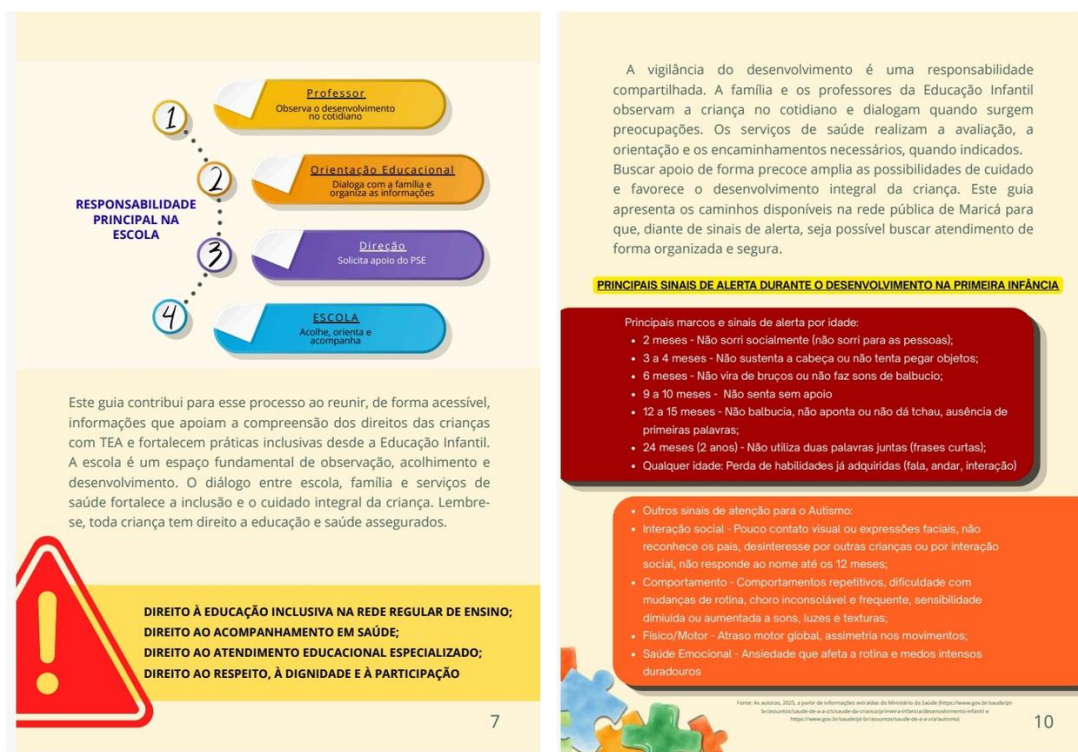
Capítulos abordados	Principais temas destacados
Apresentação do Guia	Introduz o objetivo do material e contextualiza sua importância para famílias e profissionais.

O que é o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e por que falar de diagnóstico precoce.	Apresenta conceitos fundamentais sobre o TEA, com ênfase na primeira infância e na importância da identificação.
Direitos da criança com TEA e Educação Inclusiva.	Sistematiza os direitos assegurados às crianças com TEA, destacando o papel da escola e das políticas públicas municipais.
Vigilância do desenvolvimento: quando acender o alerta.	Orienta sobre sinais de alerta no desenvolvimento infantil, reforçando a observação cotidiana como responsabilidade compartilhada.
Percurso institucional em Maricá: papéis e responsabilidades no atendimento ao TEA	Apresenta, por meio de esquemas visuais e fluxogramas, o percurso institucional de atendimento no município, delimitando claramente os papéis da família, da escola e dos serviços de saúde.
Articulação entre saúde e educação: cuidar juntos.	Destaca a importância da atuação intersetorial, com ênfase no Programa Saúde na Escola (PSE) e nos espaços de formação e apoio às escolas.
Orientações práticas finais do desenvolvimento e busca por informações oficiais.	Reúne recomendações objetivas para famílias e profissionais, incluindo organização de documentos e acompanhamento.

Fonte: A autora, 2025.

A estrutura de organização do guia foi pensada a partir de linguagem simples, direta e não técnica, com recurso visual para favorecer a leitura dinâmica e a compreensão do percurso apresentado. A opção pelo formato digital em PDF buscou ampliar as possibilidades de circulação, compartilhamento e atualização do material. O cuidado com a clareza textual e com a disposição das informações buscou respeitar a diversidade dos públicos usuários, evitando sobrecarga de informações e priorizando orientações objetivas.

Figura 5: Exemplos de páginas do Produto Educacional



Fonte: A autora, 2025.

O guia foi estruturado em seções curtas, objetivas e interdependentes, combinando texto em linguagem objetiva, quadros informativos, checklists e esquemas visuais, para auxiliar na compreensão do conteúdo por leitores não especializados.

Figura 6: Estrutura do Produto Educacional com checklist dos sinais de TEA e fluxograma orientador do percurso institucional



O guia apresenta potencial de utilização que pode favorecer maior alinhamento entre os diferentes atores envolvidos no cuidado da criança, a fim de reduzir percursos fragmentados. Sua concepção dialoga com os princípios da educação inclusiva, da atenção integral à infância e da intersetorialidade, reafirmando a importância de estratégias que favoreçam a comunicação clara, a organização do cuidado e a efetivação de direitos.

Figura 7: Esquema com síntese do percurso institucional, desde a observação inicial do desenvolvimento da criança até o acompanhamento intersetorial, articulando família, escola e serviços de saúde.

ETAPA DO PERCURSO	QUEM ATUA	O QUE É FEITO	RESULTADO ESPERADO
Observação do desenvolvimento	Família e Professor(a) da Educação Infantil	Observam como a criança se comunica, interage e se comporta no dia a dia	Identificação de sinais que merecem atenção
Diálogo escola-família	Orientador Educacional e Professor(a) da Educação Infantil e responsáveis	Compartilham observações e orientam a busca por avaliação em saúde	Família informada e orientada sobre os próximos passos
Acolhimento na Atenção Primária à Saúde	Equipe da Unidade de Saúde Básica de referência	Realiza escuta qualificada, avaliação inicial do desenvolvimento e acompanhamento	Definição da necessidade de acompanhamento ou encaminhamento
Avaliação especializada	Serviços especializados da rede pública	Realizam avaliação mais aprofundada e orientam estratégias de cuidado	Planejamento do acompanhamento conforme necessidades da criança
Acompanhamento intersetorial	Saúde, Família e Educação	Saúde acompanha clinicamente; a escola promove práticas inclusivas e a família participa de todo o processo	Continuidade do cuidado e inclusão da criança na rede regular

Fonte: As autoras, 2025.

Fonte: A autora, 2025.

As informações organizadas neste Guia, de forma sucinta e com recursos visuais disponíveis, facilitam o entendimento e a compreensão do percurso desde a observação até o acompanhamento terapêutico.

Figura 8: Orientações práticas finais: Resumo da rede de atendimento de Maricá



Fonte: A autora, 2025.

Em suma, o *Guia de percurso em saúde e educação para crianças da Educação Infantil com TEA na rede municipal de Maricá* configura-se como um produto educacional alinhado às necessidades identificadas na pesquisa, na compreensão do funcionamento da rede municipal e para contribuir com práticas institucionais de atenção e observação compartilhadas pela educação e saúde, no contexto do Programa Saúde na Escola.

6.2. ESTRATÉGIAS DE IMPLEMENTAÇÃO E ALCANCE DO GUIA

Ao projetar a chegada deste Guia aos setores públicos, a experiência cotidiana na rede aponta para a escola como o principal ponto de partida. Entende-se que a unidade escolar é, muitas vezes, o primeiro espaço público acessado pelas famílias em Maricá e o local onde as primeiras dúvidas sobre o desenvolvimento infantil ganham corpo. Portanto, a escola não é apenas um local de entrega do material, mas espaço estratégico onde o produto pode começar a ser disseminado.

Observa-se que, ao instrumentalizar os profissionais da educação com este Guia, as orientações podem ser fornecidas de maneira mais rápida e assertiva. O objetivo é que o educador, ao notar sinais de alerta, possa oferecer um mapa seguro

para a família, evitando itinerários equivocados, esperas desnecessárias e as incertezas que costumam marcar o início dessa jornada. Complementarmente, a disponibilização do material no site oficial da Prefeitura amplia essa democratização, garantindo que a informação oficial esteja a um clique de distância, tanto para o servidor quanto para o cidadão.

Nesse contexto, a parceria universidade-escola consolida-se como o motor dessa engrenagem. Essa relação deve ser compreendida como uma via de mão dupla: a universidade sistematiza o conhecimento científico e os fluxos institucionais, enquanto a escola valida esse saber na prática do "chão da rede". Essa união se fortalece em momentos de formação continuada, transformando o Guia em um objeto de estudo comum que auxilia o professor a mediar o diálogo com a saúde.

Por fim, diminuir a distância entre o que é proposto legalmente e a implementação real da política exige que a informação circule sem barreiras. Ao traduzir normas jurídicas em um percurso visual e prático, busca-se mitigar a fragmentação dos serviços. Para que o direito garantido no papel se transforme em acesso real, é preciso que o fluxo institucional seja conhecido por quem acolhe a família na ponta, permitindo que a intersetorialidade deixe de ser um conceito abstrato e se torne uma prática de cuidado integral em Maricá.

6.3. ALCANCE E LIMITAÇÕES DO PRODUTO

A elaboração deste Guia de Percurso partiu do compromisso em sistematizar e democratizar o acesso às informações sobre o atendimento ao TEA em Maricá. No entanto, cabe reconhecer que a eficácia de um material informativo encontra limites nas complexidades práticas da gestão pública e nas barreiras estruturais do cotidiano.

Um ponto central a ser considerado é a dicotomia entre o fluxo ideal estabelecido pelas normativas e documentos oficiais aqui mapeados e o fluxo real vivenciado pelas famílias. O Guia descreve o percurso institucional tal como deve ocorrer; contudo, a implementação prática dessas políticas enfrenta desafios que transcendem o escopo de um material informativo, como a eventual sobrecarga dos serviços especializados, o tempo de espera para diagnósticos e as dificuldades socioeconômicas que podem impactar a assiduidade das famílias aos tratamentos.

Ademais, dada a natureza dinâmica da administração municipal, o Guia possui uma limitação temporal. A rede de cuidados de Maricá está em constante transformação e pode passar por atualizações em seus programas, equipamentos, ampliação de serviços e mudanças de vinculação as secretarias de governo, o que demanda um esforço contínuo de revisão deste material para que ele permaneça como uma ferramenta de orientação fidedigna.

Dessa forma, este produto é direcionado a um público específico e estratégico: as famílias de crianças com sinais de risco ou diagnóstico de TEA, bem como os profissionais que atuam na ponta, especialmente na rede de ensino e nas unidades de Atenção Primária à Saúde (APS). Compreende-se, portanto, que o Guia não encerra em si a solução para a fragmentação dos serviços, mas atua como um instrumento de navegação indispensável para fortalecer a intersetorialidade e reduzir a distância entre o direito garantido no papel e o acesso efetivo à saúde e à educação no município.

7. CONCLUSÃO

A partir do desenvolvimento dessa dissertação podemos concluir que:

1. Os achados da revisão de literatura evidenciaram consenso quanto à importância do diagnóstico e da intervenção precoces no TEA, destacando o papel estratégico da Educação Infantil e da Atenção Primária à Saúde na vigilância do desenvolvimento infantil. A literatura também destacou a necessidade de práticas intersetoriais efetivas, com articulação contínua entre educação, saúde e família.
2. A análise documental permitiu identificar que os documentos nacionais oferecem diretrizes consistentes para a vigilância do desenvolvimento, a atenção precoce e a organização do cuidado em rede, especialmente por meio da Linha de Cuidado para Pessoas com TEA, do Marco Legal da Primeira Infância, da Política Nacional de Atenção Precoce e das normativas do Programa Saúde na Escola. Tais documentos reafirmam a importância dos cuidados à primeira infância estruturados no compartilhamento de responsabilidades entre os setores de educação e saúde.
3. No contexto do município de Maricá, observou-se que, embora existam avanços significativos na ampliação da rede de serviços e no investimento em políticas

inclusivas, ainda há fragilidades na sistematização do caminho a ser trilhado para o uso de todos os recursos públicos no atendimento a crianças com TEA. A clareza sobre papéis institucionais, responsabilidades compartilhadas e etapas do percurso de atendimento mostra-se fundamental para fortalecer a vigilância do desenvolvimento infantil, favorecer a identificação precoce do TEA e garantir o cuidado integral às crianças na Educação Infantil.

4. Os dados coletados foram fundamentais para subsidiar a elaboração de um produto educacional, na forma de um guia digital, que sistematize e torne acessível o percurso institucional de atendimento às crianças da primeira infância com sinais de alerta para TEA, facilitando o acesso dos familiares e responsáveis à rede de serviços disponível.

5. A elaboração do produto educacional, o guia digital de percurso em saúde e educação, constituiu-se como um instrumento de apoio às famílias, com orientações objetivas sobre os sinais de atenção que não devem ser ignorados, onde buscar apoio, quem acionar em cada etapa e como compreender o funcionamento da rede municipal de Maricá.

6. Espera-se que este estudo contribua para o fortalecimento das práticas intersetoriais no município, para a qualificação do atendimento às crianças com TEA na Educação Infantil e para a ampliação do acesso das famílias às informações sobre seus direitos e sobre o percurso institucional disponível.

Por fim, reconhece-se que esta pesquisa não esgota a temática, indicando a necessidade de estudos futuros que aprofundem a análise da efetiva implementação de políticas intersetoriais no nível local, incluindo investigações empíricas sobre a experiência das famílias e dos profissionais da educação e saúde. Ainda assim, acredita-se que os resultados apresentados e o guia elaborado representam uma contribuição relevante para a promoção da inclusão, do cuidado integral e do desenvolvimento das crianças com TEA na rede pública municipal de Maricá.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aquino, J. **Centro Universitário UNA Pouso Alegre**. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstreams/c9ffafb5-5280-4aac-84cb-1d949e5dd9d/download>. Acesso em: 5 mar. 2025.

Bardin, Laurence. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

Bragança, J. de A. et al. Benefícios da intervenção precoce no diagnóstico e tratamento de crianças com transtorno do espectro autista. *In: Saúde pública e saúde coletiva: abordagens e práticas para o bem-estar social 2*. [S. l.]: Atena, 2025. cap. 4. DOI: <https://doi.org/10.22533/at.ed.378122507044>. Acesso em: 4 jul. 2025.

Brasil. Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016. Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e dá outras precauções. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 9 mar. 2016. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm. Acesso em: 9 maio 2025.

Brasil. Ministério da Saúde. **Caderno do gestor do PSE** [recurso eletrônico]. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_gestor_PSE_1ed.pdf. Acesso em: 21 out. 2025.

Brasil. Ministério da Saúde. **Diretrizes de estimulação precoce**: crianças de zero a 3 anos com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-pessoa-com-deficiencia/publicacoes/diretrizes-de-estimulacao-precoce-criancas-de-zero-a-3-anos-com-atraso-no-desenvolvimento-neuropsicomotorpdf/view>. Acesso em: 21 jul. 2025.

Brasil. Ministério da Saúde. **E-book Passo a Passo PSE** - Programa Saúde na escola. Brasília: MS, 2011. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/passos_a_passo_programa_saude_escola.pdf. Acesso em: 15 nov. 2025.

Castilho, C. et al. Efeitos da hipoterapia no desenvolvimento psicomotor da criança autista: relato de caso. **Colloquium Vitae**, v. 10, n. 1, p. 68-73, maio 2018. Disponível em: <https://revistas.unoeste.br/index.php/cv/article/view/1564>. Acesso em: 20 maio 2025.

Ferreira, Vânia da Silva; Grossi, Fabiana Regina da Silva. O papel da colaboração escola-família na inclusão escolar de um adolescente com autismo. **Revista Nova Paideia - Revista Interdisciplinar em Educação e Pesquisa**, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 1005–1016, 2024. DOI: 10.36732/riep.v6i3.602. Disponível em: <https://ojs.novapaideia.org/index.php/RIEP/article/view/602>. Acesso em: 4 jul. 2025.

Gomes, L. B.; De Sousa, M. N. A. Intervenção precoce no tratamento de crianças do Espectro Autista. **Revista Brasileira de Revisão de Saúde**, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 3968–3978, 2023. DOI: 10.34119/bjhrv6n1-307. Disponível em:

Mota, Ana Carolina Wolff et al. Família, escola e especialista como contextos de desenvolvimento da criança com autismo: introdução. *In: Autismo: caminhos para a inclusão*. [S. l.]: Corporación Universitaria Iberoamericana, 2020. cap. 4, p. 63-82. Disponível em: <https://repositorio.ibero.edu.co/server/api/core/bitstreams/b9592688-bd08-4433-8a6c-0d7565afb822/content>. Acesso em: 10 set. 2024.

Onzi, F. Z.; Gomes, R. de F. Transtorno do espectro autista: a importância do diagnóstico e reabilitação. **Caderno Pedagógico**, [S. l.], v. 12, n. 3, 2015. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/1293>. Acesso em: 20 maio 2025.

Prudente, J. S. et al. Abordagem multidisciplinar no tratamento do autismo: desafios e estratégias terapêuticas. **Revista FT**, v. 29, n. 144, mar. 2025. DOI: 10.69849/revistaft/pa10202503151825. Disponível em: <https://revistaft.com.br/abordagem-multidisciplinar-no-tratamento-do-autismo-desafios-e-estrategias-terapeuticas/>. Acesso em: 4 jul. 2025.

Quirino, G. S. et al. Atualizações sobre triagem, diagnóstico e manejo do transtorno do espectro autista. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 25, e19469, 2025. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e19469.2025>. Acesso em: 4 jul. 2025.

Romeu, Clariana Andrioli; Rossit, Rosana Ap. Salvador. Trabalho em Equipe Interprofissional no Atendimento à Criança com Transtorno do Espectro do Autismo. **Revista Brasileira de Educação Especial**, Marília, v. 28, e0114, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-54702022v28e0114>. Acesso em: 29 jun. 2025.

Rosa, J. M. et al. Sinais clínicos e barreiras no diagnóstico precoce do TEA: uma revisão integrativa. **Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana**, v. 23, n. 6, 2025. DOI: 10.55905/oelv23n6-173. Acesso em: 4 jul. 2025.

Saad, Amanda Pereira Risso; Bastos, Paulo Roberto Haidamus de Oliveira; Souza, Geisa Alessandra Cavalcante de. Perspectivas Profissionais e Maternas no Transtorno do Espectro Autista: Paradigmas e Cuidados em Saúde Mental. **Revista Psicologia e Saúde**, Campo Grande, v. 16, e1692476, jan. 2024. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-093X2024000100208. Acesso em: 9 mar. 2025.

Salgado, N. D. M. et al. Transtorno do espectro do autismo em crianças: uma revisão sistemática do aumento da incidência e do diagnóstico. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 13, e512111335748, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i13.35748. Acesso em: 4 jul. 2025.

Schmidt, C. Transtorno do espectro autista: onde estamos e para onde vamos. **Psicologia em Estudo**, v. 22, n. 2, p. 221-230, 2017. DOI: <https://doi.org/10.4025/psicolestud.v22i2.34651>. Acesso em: 5 set. 2024.

Shaw, K. A. et al. Prevalence and Early Identification of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 4 and 8 Years — Autism and Developmental Disabilities

Monitoring Network, 16 Sites, United States, 2022. **MMWR. Surveillance Summaries**, 2022.

Silva, A. M. de O. da; Sousa, F. do N.; Silva, M. G. da. Inclusão de alunos com autismo em sala de aula. **Revista Foco**, [S. l.], v. 17, n. 5, p. e5017, 2024. DOI: 10.54751/revistafoco.v17n5-003. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/5017>. Acesso em: 19 maio 2025.

Silva, A. M. V. da; Bastos, J. M. Desafiando barreiras: O transtorno do espectro do Autista e escolas públicas e suas implicações para a prática educacional. **Revista FT**, v. 29, n. 143, 2025. Disponível em: <https://revistaft.com.br/desafiando-barreiras-o-transtorno-do-espectro-autista-em-escolas-publicas-e-suas-implicacoes-para-a-pratica-educacional/>. Acesso em: 4 jul. 2025.

Sociedade Brasileira de Pediatria. **Manual de Orientação Transtorno do Espectro do Autismo**. Rio de Janeiro: SBP, n. 5, 2019. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Ped.Desenvolvimento-21775b-MO-Transtorno_do_Espectro_do_Autismo.pdf. Acesso em: 8 jan. 2025.

Viana, A. C. V. et al. Autismo: uma revisão integrativa. **Saúde Dinâmica**, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 1–18, 2020. DOI: 10.4322/2675-133X.2022.017. Disponível em: <https://revista.faculdaadedinamica.com.br/index.php/sausedinamica/article/view/40>. Acesso em: 4 mar. 2025.

Viana, G. A. et al. Transtornos do Espectro Autista ao longo do desenvolvimento humano. **Revista Brasileira de Revisão de Saúde**, [S. l.], v. 6, n. 5, p. 19571–19580, 2023. DOI: 10.34119/bjhrv6n5-010. Acesso em: 20 maio 2025.

Wanderley, Mariangela Belfiore; Martinelli, Maria Lúcia; Paz, Rosangela Dias O. da. Intersetorialidade nas políticas públicas. **Serviço Social & Sociedade**, São Paulo, n. 137, p. 7-13, jan./abr. 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0101-6628.198>. Acesso em: 24 abr. 2026.

VIANA, G. A.; SANTOS, M. F. R. dos; CAVICHINI, P. A.; MARTINS, V. B. Transtornos do espectro autista ao longo do desenvolvimento humano. *Brazilian Journal of Health Review*, [S. l.], v. 6, n. 5, p. 19571-19580, 2023. DOI: <https://doi.org/10.34119/bjhrv6n5-010>. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/62709> . Acesso em: 20 maio 2025.

WANDERLEY, Mariangela Belfiore; MARTINELLI, Maria Lúcia; PAZ, Rosangela Dias O. da. Intersetorialidade nas políticas públicas. *Serviço Social & Sociedade*, São Paulo, n. 137, p. 7-13, jan./abr. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/0101-6628.198>. Acesso em: 24 abr. 2026.

9. APÊNDICE A

9.1. PERCURSO DETALHADO DE NAVEGAÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL

O procedimento de busca no site oficial foi realizado em etapas sequenciais, descritas a seguir:

Etapa 1 – Acesso ao portal institucional

A busca teve início no site oficial da Prefeitura Municipal de Maricá (<https://www.marica.rj.gov.br/>), que reúne informações sobre a estrutura administrativa, secretarias, serviços e políticas públicas do município.

Etapa 2 – Navegação pelo menu institucional

Na página inicial, foi selecionado o menu “Prefeitura”, seguido do item “Secretarias”, que direciona o usuário à página que apresenta a organização administrativa municipal. Nessa seção, encontram-se listadas todas as secretarias de governo e órgãos responsáveis pela execução das políticas públicas locais.

1. Página Inicial → Menu "Secretarias" → Secretaria de Assistência Social e Cidadania : Identifique subseções "Serviços" e "Equipamentos": Casa do Autista (Figura 2); Centro de Reabilitação (Figura 3); Serviço de Atendimento e Reabilitação Especial em Maricá -SAREM (Figura 4); Equoterapia (Figura 5); Centro de Referência em Políticas Inclusivas de Maricá - CAIF (Figura 6).
2. Retornar "Secretarias" → Secretaria de Educação → "Programas da Educação" (27 iniciativas): Opção "Inclusão Educacional" (Sala de Recursos Multifuncionais, mediadores, APD (Atendimento Pedagógico Domiciliar), Libras, Braille, Jornada da Diversidade.
3. "Secretarias" → Secretaria da Pessoa com Deficiência e Inclusão → (emissão passe especial, aparelhos auditivos, transporte conveniadas: Associação

Niteroiense de Deficientes Físicos (ANDEF), Pestalozzi, Associação Fluminense de Reabilitação (AFR); equipe: fonoaudiólogo, assistente social).